Painéis de Indicadores · Maternidades Estratégicas · 2019 a 2025 e 1º semestre de 2026

Apostila dos Dicionários de Dados

Painéis de Nascimentos, Internação e Mortalidade das Maternidades Estratégicas

Qualificação do Modelo de Gestão em Maternidades Estratégicas na Rede de Atenção à Saúde Materna e Neonatal

Coordenação de Ações Nacionais e de Cooperação em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)

Ministério da Saúde

Versão 1.3 · Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2026

Documento de trabalho da equipe. Reproduz os dicionários e as páginas de metodologia aprovados em cada projeto (listados nas referências, seção 9), com as regras em vigor nos painéis publicados em https://anamazza.github.io/Indicadores_Brasil/. Dados: bases públicas do Ministério da Saúde (SINASC, SIH/SUS, SIM e CNES), 2019 a 2025 e 1º semestre de 2026, sujeitos a revisão.

Sumário

1. Apresentação
   - 1.1 O que é esta apostila
   - 1.2 Como usar
   - 1.3 Como os painéis estão organizados
   - 1.4 Controle de versões
2. Fontes de dados
3. Unidades e grupos
   - 3.1 Os três grupos de maternidades
   - 3.2 A coluna de referência do comparador em cada painel

4. Dicionário do Painel de Nascimentos (SINASC)
   4.1 Bases usadas pelo painel
   4.2 Indicadores dos mapas e do comparador
   4.3 Demais cálculos do painel
   4.4 Perfil da mãe (quadros do dossiê)
   4.5 Tabelas do dossiê (blocos de nascidos vivos)
   4.6 Grupos de Robson
5. Dicionário do Painel de Internação (SIH/SUS)
   5.1 Comparador e destaques
6. Dicionário do Painel de Mortalidade (SIM)
   6.1 Notas metodológicas do dicionário
   6.2 Indicadores dos mapas e do comparador
7. Notas comuns aos três painéis
   7.1 Notas gerais
   7.2 Situação dos anos preliminares, por base e painel
8. Glossário de siglas e termos
9. Referências
   9.1 Bases de dados e sistemas
   9.2 Normas
   9.3 Documentos técnicos oficiais
   9.4 Artigos científicos citados nos dicionários
   9.5 Documentos do projeto

1. Apresentação

1.1 O que é esta apostila

Esta apostila reúne, em um único documento, as definições e as regras de cálculo dos indicadores dos três painéis das maternidades estratégicas, tal como registradas nos dicionários aprovados e nas páginas de metodologia dos painéis. Os painéis são: Nascimentos, com dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC); Internação, com dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS); e Mortalidade, com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

Ela foi escrita para toda a equipe, em linguagem direta. O objetivo é que qualquer pessoa consiga responder a uma pergunta frequente: de onde vem cada número do painel e da apresentação. As siglas são explicadas na primeira vez em que aparecem e estão reunidas no glossário (seção 8).

O conteúdo reproduz os documentos aprovados em cada projeto. Nada foi criado fora deles. Quando um dicionário registra uma decisão da coordenação, a data da decisão aparece junto da regra. A apostila deve ser atualizada sempre que um dos documentos de origem mudar (seção 1.4). Os registros de auditoria, validação e revisão dos painéis ficam em documentos próprios e não fazem parte deste dicionário.

1.2 Como usar

Cada indicador aparece com três informações: o que mede, como é calculado (as variáveis das bases e os códigos usados) e a fonte dos dados. Os códigos de diagnóstico seguem a Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão (CID-10). Os códigos de procedimento e de ato profissional (os atos registrados em cada internação) seguem a Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (SIGTAP). Os códigos de leito seguem o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Nomes em letras maiúsculas, como PROC_REA e IDADEMAE, são os nomes dos campos nos arquivos do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Quando a regra tem limitações conhecidas, elas estão registradas na mesma linha.

Um termo aparece em quase todas as regras: registros ignorados. São os registros em que o campo está em branco ou preenchido com o código de "ignorado" (por exemplo, 9, 99 ou 9999). Salvo indicação em contrário, eles ficam fora do numerador e do denominador do indicador.

Exemplo de leitura de um indicador. "% de cesárea" de uma maternidade em 2025: o numerador é o número de partos cesáreos; o denominador é o número de nascidos vivos com via de nascimento informada (os registros com via ignorada ficam fora). Se a unidade teve 640 cesarianas em 1.000 nascidos vivos com via informada, o indicador é 64,0%. É um indicador do tipo "quanto menor, melhor". No comparador do Painel de Nascimentos, a unidade é comparada com a taxa agregada do seu grupo: se o grupo teve 57,2%, a unidade aparece 6,8 pontos percentuais acima da média do grupo. Nas taxas por mil ou por cem mil (como a razão de mortalidade materna), vale ler sempre o número absoluto junto com a taxa, porque em unidades com poucos nascidos vivos um único óbito produz valores altos.

A seção 2 descreve as bases de dados. A seção 3 explica quais unidades entram nos painéis e como funciona a comparação com a média do grupo. As seções 4, 5 e 6 são os dicionários de cada painel. A seção 7 reúne as notas comuns aos três painéis. A seção 8 é o glossário e a seção 9, as referências.

1.3 Como os painéis estão organizados

Os três painéis têm a mesma estrutura. Os termos abaixo aparecem ao longo da apostila com o significado que têm na tela dos painéis.

Tabela 1 – Partes e termos dos painéis

Termo	O que é
Mapa do Brasil	Mapa coroplético por unidade da federação (UF), macrorregião ou região de saúde, com filtros e faixas de cor recalculadas por recorte; existe nos painéis de Nascimentos e de Mortalidade.
Mapa de unidades	Mapa com um ponto por maternidade, colorido por grupo, com filtros, busca e pontos de contexto (estabelecimentos com 480 ou mais partos por ano, segundo o SIH/SUS de 2025).
Botão Página principal	Único botão de navegação no alto de cada painel; volta à página principal dos painéis.
Dossiê da unidade	Página de detalhe de cada maternidade: ficha de cadastro CNES, habilitações ativas (serviços que o SUS autoriza o estabelecimento a realizar) e todas as tabelas da apresentação, com gráficos ao clicar nos anos e nos rótulos; permite baixar em PDF.
Blocos e quadros	As tabelas do dossiê (chamadas blocos) e os quadros de perfil da mãe (chamados cards no código do painel).
Comparador	Tela que compara de duas a quatro unidades do mesmo grupo, por ano, com uma coluna de referência do grupo (seção 3.2), e a mesma unidade entre anos (variação e tendência).
Destaque de melhor posição	Realce que o comparador dá à unidade com o melhor resultado em cada indicador que tem direção definida (quanto maior ou quanto menor, melhor).
Comparativo entre anos	Dois mapas lado a lado do mesmo indicador, com faixas de cor comuns (Nascimentos e Mortalidade).
Metodologia	Página própria de cada painel com as fontes oficiais e a ficha de numerador e denominador de cada cálculo. É de lá que vêm as fichas reproduzidas nesta apostila.
Seletores e filtros	Listas em que o usuário escolhe grupo, unidade, ano e território.

1.4 Controle de versões

Tabela 2 – Histórico de versões da apostila

Versão	Data	O que mudou	Responsável
1.0	11/10/2026	Primeira versão, compilada a partir dos dicionários e das páginas de metodologia aprovados em cada projeto (referências, seção 9).	Coordenação (equipe dos painéis)
1.1	11/10/2026	Revisão: correções nos textos de ligação, novas seções 1.3, 4.5, 4.6, 5.1 e 6.2, glossário e referências ampliados, identidade visual e acessibilidade ajustadas. O material de auditoria e validação passou ao parecer da revisão, fora deste dicionário.	Coordenação (equipe dos painéis)
1.2	18/10/2026	Período parcial: os painéis passaram a trazer a coluna "1º sem. 2026" (janeiro a junho de 2026, dados preliminares). Atualizados o período na capa e na seção 2, a nota de dados preliminares e a tabela da seção 7.2, e acrescentada a nota "Período parcial" na seção 7.1. Nenhuma regra de cálculo mudou.	Coordenação (equipe dos painéis)
1.3	18/10/2026	Retirada, a pedido da coordenação, a seção "Documentos de origem" (antiga 1.4); os documentos continuam citados nas referências (seção 9), e o controle de versões passou a ser a seção 1.4. Textos de ligação revisados para o registro formal, com citação das fontes oficiais e dos documentos aprovados no lugar das etapas internas de trabalho. Nenhuma regra de cálculo mudou.	Coordenação (equipe dos painéis)

Responsável pela atualização: a coordenação, por meio da equipe dos painéis, sempre que um documento de origem for alterado. Contato: pela coordenação, no IFF/Fiocruz.

2. Fontes de dados

Todos os indicadores vêm de bases públicas do Ministério da Saúde: SINASC, SIH/SUS, SIM e CNES. A tabela resume o que cada base registra, como ela chega aos painéis e a situação dos dados. Os arquivos do DATASUS são obtidos no seu servidor de arquivos (FTP) ou no OpenDataSUS, o portal de dados abertos do Ministério da Saúde.

Tabela 3 – Bases de dados dos painéis

Base	O que registra	Como chega aos painéis	Período e situação
SINASC	Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Cada nascido vivo é registrado a partir da Declaração de Nascido Vivo (DN).	Microdados (registros individuais, um por nascimento) publicados no OpenDataSUS, em um arquivo por ano. No Painel de Nascimentos, as séries por unidade e por território são tabuladas a partir desses microdados, segundo o estabelecimento de ocorrência (campo CODESTAB) e os municípios de residência e de ocorrência da mãe, com as categorias descritas na seção 4.5. No Painel de Mortalidade, o SINASC fornece os nascidos vivos usados como denominador. No Painel de Internação, fornece três indicadores calculados na DN: parto vaginal após cesariana, trabalho de parto induzido e condições potencialmente ameaçadoras à vida do recém-nascido. Os quadros de perfil da mãe estão no Painel de Nascimentos (seção 4.4).	2019 a 2025 e 1º semestre de 2026 (nascidos de janeiro a junho de 2026, do arquivo preliminar de 2026 do OpenDataSUS, extraídos em 18/10/2026). No Painel de Nascimentos e no de Internação, 2025 é preliminar; no Painel de Mortalidade, 2024 e 2025 recebem a marca de preliminar (seção 7.3). Dados sujeitos a revisão.
SIH/SUS	Sistema de Informações Hospitalares do SUS. A Autorização de Internação Hospitalar (AIH) registra cada internação financiada pelo SUS.	Arquivos públicos da AIH reduzida (RD, um registro por internação) e de serviços profissionais (SP, um registro por procedimento ou ato realizado na internação), no FTP do DATASUS, por unidade da federação (UF) e por competência. Competência é o mês em que a internação foi processada e paga, que pode ser meses depois da alta; por isso os arquivos de 2026 são necessários para completar 2024 e 2025. O ano de referência de cada internação é o da data de internação.	Competências de janeiro de 2019 a junho de 2026 para as colunas de 2019 a 2025; para o 1º semestre de 2026 (internações de janeiro a junho de 2026), competências até agosto de 2026. 2025 sujeito a acréscimos nas próximas competências.

CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde: ficha de cadastro, habilitações e leitos de cada estabelecimento.	A ficha de cadastro vem do serviço de acesso automatizado (API) de Dados Abertos do Ministério da Saúde; as habilitações ativas vêm do portal do CNES na internet. Os leitos usados nas taxas de ocupação vêm dos arquivos LT, que informam os leitos de cada estabelecimento mês a mês.	Ficha e habilitações atualizadas semestralmente, em 1º de junho e 1º de dezembro, a partir das fontes oficiais; última atualização em 11/10/2026, informada na página principal dos painéis.
SIM	Sistema de Informações sobre Mortalidade: Declarações de Óbito (DO) e Declarações de Óbito Fetal (DOFET).	Arquivos DO<UF><ano>.dbc (um por estado e ano; por exemplo, DORJ2023.dbc) e DOFET<aa>.dbc (arquivo nacional, ano com dois dígitos; por exemplo, DOFET23.dbc), no FTP do DATASUS. Todas as UFs são lidas, porque o óbito é contado na unidade onde ocorreu, independentemente da residência.	2019 a 2025; extração em 10 e 11/09/2026 e, para as unidades acrescentadas, em 23/09/2026. 1º semestre de 2026: óbitos de janeiro a junho de 2026, dos arquivos preliminares de 2026 (28/09/2026), extraídos em 18/10/2026. 2024, 2025 e o 1º semestre de 2026 tratados como preliminares no painel (seção 7.2).
Base territorial e malhas	Limites de estados, das 121 macrorregiões de saúde e das 439 regiões de saúde, e a tabela município → região de saúde → macrorregião.	Os mapas usam malhas oficiais dos projetos de regionalização, compactadas para a tela. As linhas de território das tabelas usam a base territorial do DATASUS (versão de junho de 2026). A regionalização é a vigente, idêntica, nos territórios examinados, nas seis versões testadas entre 2023 e junho de 2026.	Usadas nos mapas e nas linhas de território das tabelas.

3. Unidades e grupos

3.1 Os três grupos de maternidades

Cada unidade dos painéis pertence a pelo menos um de três grupos: maternidades estratégicas (rotuladas "apoiadas" na lista oficial e nos painéis de Internação e de Mortalidade), unidades da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e maternidades do QUALINEO, ciclo 2026/2027. Algumas unidades pertencem a dois ou três grupos, por exemplo, hospitais universitários da EBSERH que também são maternidades estratégicas.

Nos painéis de Internação e de Mortalidade, as unidades e os grupos seguem, desde 9 de setembro de 2026, a lista oficial de maternidades por grupo definida pela coordenação em 9 de setembro de 2026, com 115 estabelecimentos (códigos CNES distintos). Uma unidade classificada como "apoiada/QUALINEO" conta nos dois grupos. O Painel de Nascimentos mantém a composição de grupos definida em agosto de 2026; por isso, a média do grupo de uma mesma unidade pode diferir entre os painéis.

Tabela 4 – Unidades por grupo em cada painel, em 11 de outubro de 2026 (uma unidade pode contar em mais de um grupo)

Grupo	Painel de Nascimentos	Painel de Internação	Painel de Mortalidade
Maternidades estratégicas (apoiadas)	63	58	59
Unidades EBSERH	25	25	25
QUALINEO 2026/2027	35	86	86
Total de unidades no painel	118	119	120

As unidades pedidas pela coordenação depois da lista oficial entram nos painéis com as mesmas regras. Quando não constam da lista oficial, aparecem identificadas como acrescentadas ("anexo"). Em 11 de outubro de 2026, a situação era a seguinte:

- **Painel de Internação (119 unidades):** anexos Maternidade Carmosina Coutinho (Caxias/MA, CNES 2453665), Santa Casa de Misericórdia de Sobral (CE, CNES 3021114), Santa Casa de Franca (SP, CNES 2705982) e Hospital Dr. Claudionor Couto Roriz (RO, CNES 2495279). O CISAM e o Hospital da Mulher do Recife (PE), acrescentados em 12 de setembro de 2026, constam da lista oficial e não são anexo.
- **Painel de Mortalidade (120 unidades):** anexos Carmosina Coutinho, Santa Casa de Sobral e Santa Casa de Franca (acrescentadas em 23 de setembro de 2026), Hospital do Rocio (PR, CNES 0013846) e Unidade Hospitalar de Iauaretê (AM, CNES 2717387).

- **Painel de Nascimentos (118 unidades):** sem marcação de anexo; as unidades acrescentadas em setembro entram nos grupos definidos em agosto.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), Marília/SP: no Painel de Mortalidade, os CNES 2025507 (hospital adulto) e 2025523 (unidade materno-infantil) são tratados como um único complexo, com os óbitos dos dois códigos e os nascidos vivos do 2025523 (dicionário de 11/09/2026). Nos painéis de Nascimentos e de Internação, a unidade aparece pelo CNES 2025507.

3.2 A coluna de referência do comparador em cada painel

A coluna de referência do comparador é calculada de forma diferente em cada painel. É importante explicar isso à equipe, porque a mesma unidade pode ter referências diferentes conforme o painel.

Painel de Nascimentos: taxa agregada do grupo

As regras abaixo são as da nota metodológica de agosto de 2026 e valem para todos os anos de 2019 a 2025 e para o acumulado do período.

- **Indicadores percentuais:** a média não é a média aritmética das taxas das unidades. É a taxa agregada do grupo: soma dos numeradores de todas as unidades do grupo com dados no ano, dividida pela soma dos denominadores, multiplicada por 100. Cada indicador usa o mesmo numerador e o mesmo denominador da ficha individual da unidade, com as mesmas exclusões de registros ignorados.
- **Grupos de Robson:** a taxa de cesárea de cada grupo de Robson soma as cesáreas do grupo em todas as unidades e divide pela soma dos nascidos vivos daquele grupo de Robson (na ficha do painel, "número de partos" significa nascidos vivos do grupo). É a mesma lógica de soma de numeradores e denominadores.
- **Volume de nascidos vivos:** por ser um número absoluto, usa a média por unidade: total de nascidos vivos do grupo dividido pelo número de unidades com dados no ano.
- **Só o próprio grupo:** o filtro impede comparar unidades de grupos diferentes ou uma unidade com a média de outro grupo. Unidade sem dados no ano fica fora da média daquele ano. Unidade que pertence a mais de um grupo conta na média de todos eles.
- **A coluna da média é só referência:** não participa do destaque de melhor posição, que compara apenas as unidades entre si.

Exemplo da nota: em 2025, as 25 unidades do grupo EBSERH com dados somaram 28.638 partos cesáreos em 50.084 nascidos vivos com via de nascimento informada, o que resulta em 57,2% de cesárea para o grupo. Uma unidade com 64,4% aparece 7,2 pontos percentuais acima da média do seu grupo.

Painel de Internação: média simples das unidades

No Painel de Internação, a referência é a média simples dos indicadores das unidades do grupo com dados no ano, porque, para os indicadores de internação, o painel publica os valores calculados de cada unidade, sem numeradores e denominadores. O destaque marca o maior valor nos indicadores de boas práticas (AMIU, acompanhante, parto vaginal após cesariana e analgesia) e o menor nos indicadores de morbidade (casos de morbidade materna grave e condições potencialmente ameaçadoras à vida). Fonte: página "Metodologia" do Painel de Internação.

Painel de Mortalidade: agregado do grupo

No Painel de Mortalidade, a coluna chama-se "Agregado do grupo": é a taxa agregada do grupo (soma dos óbitos dividida pela soma dos denominadores) e, nos números absolutos, a média por unidade. A coluna não participa do destaque de melhor posição. Fonte: página "Metodologia" do Painel de Mortalidade.

4. Dicionário do Painel de Nascimentos (SINASC)

O Painel de Nascimentos (chamado Painel NV 2026, de nascidos vivos) traz, desde 29 de setembro de 2026, somente os indicadores de nascimentos: os blocos de indicadores de nascidos vivos e os quadros de perfil da mãe. Os indicadores de internação passaram ao Painel de Internação (seção 5). Todos os indicadores desta seção vêm do SINASC, série 2019 a 2025, com 2025 preliminar.

Convenções: a fonte de todos os indicadores é o SINASC; nomes em letras maiúsculas são campos da Declaração de Nascido Vivo nos arquivos do DATASUS; salvo indicação em contrário, os registros ignorados ficam fora do numerador e do denominador.

4.1 Bases usadas pelo painel

Além das bases descritas na seção 2, a página "Metodologia" do painel registra três usos específicos:

Tabela 5 – Usos específicos de bases no Painel de Nascimentos

Base	Uso no painel
SIH/AIH	Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Origem do volume anual de partos por estabelecimento e dos pontos de contexto do mapa de unidades (estabelecimentos com 480 ou mais partos/ano, produção de 2025).
Malhas territoriais	Limites de estados, macrorregiões de saúde (121) e regiões de saúde (439) compactados em SVG a partir das malhas oficiais utilizadas nos projetos de regionalização.
Comparativo entre anos	Microdados públicos do SINASC (OpenDataSUS), série 2019-2025, processados por território de residência e ocorrência: todos os nascidos vivos e <1500 g, por região de saúde, macro e UF. Nos níveis macro e UF, o percentual agrega os nascidos na própria região de saúde (todos) ou na própria macro (<1500 g), como nas planilhas oficiais. 2025 preliminar. Extração validada contra as planilhas NV por Região e NV por Macro (2019 e 2024).
Localização das unidades	Coordenadas geográficas (latitude e longitude) de cada estabelecimento, georreferenciadas a partir do cadastro CNES.

4.2 Indicadores dos mapas e do comparador

As fichas abaixo são as mesmas da página "Metodologia" do painel. Nos mapas, ao agregar territórios, somam-se os numeradores e os denominadores das maternidades da seleção; a taxa de cesárea por grupo de Robson é ponderada pelo número de nascidos vivos do grupo em cada unidade.

Tabela 6 – Indicadores dos mapas e do comparador do Painel de Nascimentos

Indicador	O que mede	Numerador	Denominador	Direção, referência e observações
Nascidos vivos ocorridos	Total de nascidos vivos ocorridos na unidade (SINASC).	Soma dos nascidos vivos ocorridos na unidade no ano (contagem simples).	Não se aplica: é um número absoluto, não uma taxa.	Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.
% dos nascimentos da UF ocorridos nas maternidades	Participação das maternidades estratégicas do território no total de nascidos vivos da UF.	Nascidos vivos ocorridos nas maternidades estratégicas da seleção.	Nascidos vivos totais da UF (com mais de uma unidade na seleção, o total da UF é contado uma única vez).	Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.
% de NV ocorridos na região de residência	Percentual dos nascidos vivos da maternidade cujas mães residem na própria região de saúde da unidade.	Nascidos vivos da unidade cuja mãe reside na região de saúde da própria unidade.	Nascidos vivos ocorridos na unidade.	Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.
% com 7 ou mais consultas de pré-natal	Nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas de pré-natal (exclui ignorados).	Nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas de pré-natal.	Nascidos vivos totais, excluídos os registros com número de consultas ignorado.	Quanto maior, melhor.
% com pré-natal iniciado no 1º trimestre	Entre quem fez ao menos uma consulta, proporção que começou no primeiro trimestre (exclui ignorados).	Nascidos vivos com pré-natal iniciado no primeiro trimestre.	Nascidos vivos com ao menos uma consulta de pré-natal, excluídos os registros com trimestre ignorado.	Quanto maior, melhor. Observação: ver a ficha "% Primeiro Trimestre" na seção 4.3.
% de cesárea	Partos cesáreos sobre o total de nascidos vivos com via informada.	Partos cesáreos.	Nascidos vivos totais, excluídos os registros com via de nascimento ignorada.	Quanto menor, melhor.
% de parto vaginal assistido por enfermeira ou obstetriz	Entre os partos vaginais, proporção assistida por enfermeira obstétrica ou obstetriz. Meta institucional ≥50%.	Partos vaginais assistidos por enfermeira ou obstetriz.	Partos vaginais, excluídos os registros com profissional ignorado.	Quanto maior, melhor. Valor de referência do painel: pelo menos 50%.

% de baixo peso (<2500 g)	Perfil de risco recebido: são maternidades de referência para gestação de alto risco.	Nascidos vivos com menos de 2500 g.	Nascidos vivos com peso ao nascer informado.	Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.
% de muito baixo peso (<1500 g)	Concentração de recém-nascidos de muito baixo peso: complexidade assumida pela unidade.	Nascidos vivos com menos de 1500 g.	Nascidos vivos com peso ao nascer informado.	Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.
% de prematuridade (<37 semanas)	Nascidos vivos com menos de 37 semanas de gestação (exclui idade gestacional não informada).	Nascidos vivos com menos de 37 semanas de gestação.	Nascidos vivos com idade gestacional informada.	Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.
% de Apgar <7 no 5º minuto	Apgar de 0 a 6 no 5º minuto, entre nascidos com ≥2500 g e sem anomalias congênitas.	Nascidos vivos com Apgar de 0 a 6 no 5º minuto.	Nascidos vivos com Apgar informado, considerando somente os com 2500 g ou mais e sem anomalias congênitas (os demais não entram nem no numerador nem no denominador).	Quanto menor, melhor.
Taxa de cesárea no grupo 1 de Robson	Nulíparas, feto único cefálico, ≥37 semanas, trabalho de parto espontâneo. Meta ≤10%.	Partos cesáreos do grupo 1 de Robson.	Nascidos vivos do grupo 1 de Robson.	Quanto menor, melhor. Valor de referência do painel: até 10%.
Taxa de cesárea no grupo 2 de Robson	Nulíparas, feto único cefálico, ≥37 semanas, parto induzido ou cesárea antes do trabalho de parto. Meta ≤35%.	Partos cesáreos do grupo 2 de Robson.	Nascidos vivos do grupo 2 de Robson.	Quanto menor, melhor. Valor de referência do painel: até 35%.
Taxa de cesárea no grupo 3 de Robson	Multíparas sem cesárea anterior, feto único cefálico, ≥37 semanas, trabalho de parto espontâneo. Meta ≤3%.	Partos cesáreos do grupo 3 de Robson.	Nascidos vivos do grupo 3 de Robson.	Quanto menor, melhor. Valor de referência do painel: até 3%.

Taxa de cesárea no grupo 4 de Robson	Multíparas sem cesárea anterior, feto único cefálico, ≥37 semanas, parto induzido ou cesárea antes do trabalho de parto. Meta ≤15%.	Partos cesáreos do grupo 4 de Robson.	Nascidos vivos do grupo 4 de Robson.	Quanto menor, melhor. Valor de referência do painel: até 15%.
Taxa de cesárea no grupo 5 de Robson	Multíparas com pelo menos uma cesárea anterior, feto único cefálico, ≥37 semanas.	Partos cesáreos do grupo 5 de Robson.	Nascidos vivos do grupo 5 de Robson.	Quanto menor, melhor.

4.3 Demais cálculos do painel

Esta seção reúne os cálculos que não são indicadores do mapa, mas aparecem no dossiê da unidade, no comparativo entre anos e no comparador.

Tabela 7 – Demais cálculos do Painel de Nascimentos

Cálculo	O que mede	Numerador	Denominador	Fonte
% Residentes no município / região de saúde / macro / UF (dossiê, perspectiva Local de residência)	Dos bebês que nascem na maternidade, quantos têm mãe moradora de cada nível territorial da unidade.	Nascidos vivos ocorridos na maternidade cuja mãe reside no nível territorial (município, região de saúde, macro ou UF da unidade).	Nascidos vivos ocorridos na maternidade.	Ministério da Saúde – SINASC, 2019 a 2025. Também calculado para os nascidos vivos <1500 g.
% Município / região de saúde / macro / UF (dossiê, perspectiva Local de ocorrência)	De todos os nascimentos que acontecem em cada território, quantos ocorrem dentro da maternidade.	Nascidos vivos ocorridos na maternidade.	Nascidos vivos ocorridos no território (município, região de saúde, macro ou UF).	Ministério da Saúde – SINASC, 2019 a 2025. Também calculado para os nascidos vivos <1500 g.
% Primeiro Trimestre (tabela de trimestre do dossiê)	Linha percentual da tabela de trimestre de início de pré-natal, no formato da apresentação.	Nascidos vivos com pré-natal iniciado no primeiro trimestre.	Total de nascidos vivos com ao menos uma consulta, incluindo os registros com trimestre ignorado (por isso pode diferir do indicador "% com pré-natal iniciado no 1º trimestre" dos mapas, que exclui os ignorados).	Ministério da Saúde – SINASC, 2019 a 2025.

% de NV ocorridos no território de residência (Comparativo entre anos)	Retenção territorial de nascimentos: das mães residentes em cada território, quantas pariram dentro do próprio território. Considera todos os nascimentos, não apenas maternidades estratégicas. Nos níveis macrorregião e UF, o percentual agrega os nascidos na própria região de saúde (recorte todos) ou na própria macro (recorte <1500 g), seguindo a semântica das planilhas oficiais.	Nascidos vivos de mães residentes que ocorreram no próprio território de residência (nível região de saúde; agregado nos níveis macro e UF).	Nascidos vivos de mães residentes no território, independentemente de onde ocorreu o parto.	Ministério da Saúde – SINASC, microdados públicos (OpenDataSUS), série 2019-2025, com 2025 preliminar. Ambos os recortes (todos e <1500 g) por região de saúde, macro e UF. Extração própria validada contra as planilhas NV por Região e NV por Macro (2019 e 2024): diferenças médias de 0,1 a 0,4 ponto percentual.
Participação da unidade nos nascimentos da UF e do Brasil (topo do dossiê)	Peso relativo da maternidade no total de nascimentos do seu estado e do país, no ano mais recente.	Nascidos vivos ocorridos na unidade em 2025.	Nascidos vivos totais da UF (SINASC) ou do Brasil — este obtido pela soma dos totais das 27 UFs.	Ministério da Saúde – SINASC, 2025.

Média do grupo (comparador)	Coluna de referência do comparador de unidades: a maternidade é comparada com a média do seu próprio grupo — maternidades estratégicas, unidades EBSERH ou QUALINEO 2026/2027. Nos indicadores percentuais a média é a taxa agregada do grupo (soma dos numeradores dividida pela soma dos denominadores de todas as unidades do grupo, com as mesmas exclusões de ignorados de cada indicador), a mesma regra de agregação usada nos mapas e no panorama; nos grupos de Robson, a taxa agregada é ponderada pelo número de partos de cada unidade no grupo. No volume de nascidos vivos, mostra-se a média por unidade (total do grupo dividido pelo número de unidades com dado no ano). Unidades que pertencem a mais de um grupo contam na média de todos os grupos a que pertencem. A média do grupo não participa do destaque de melhor posição.	Soma dos numeradores do indicador nas unidades do grupo com dado no ano.	Soma dos denominadores correspondentes nas mesmas unidades.	Ministério da Saúde – SINASC, 2019 a 2025.

4.4 Perfil da mãe (quadros do dossiê)

Os quadros de perfil da mãe seguem as regras das seções de perfil do dicionário de indicadores de internação (versão final de 10/09/2026), reproduzidas abaixo. O painel mostra sete quadros: idade, raça/cor, escolaridade, situação conjugal, cesarianas anteriores, tipo de gestação e pré-natal adequado à idade gestacional. A linha de gestações anteriores consta do dicionário, mas não está entre os sete quadros do painel.

Perfil sociodemográfico (SINASC)

Tabela 8 – Perfil sociodemográfico (SINASC): indicadores e regras

Indicador	O que mede	Variáveis e regra
Distribuição percentual dos nascidos vivos por idade da mãe	Total de nascidos vivos em cada faixa etária da mãe, dividido pelo total de nascidos vivos e multiplicado por 100.	Fonte: SINASC. IDADEMAE (idade da mãe em anos completos), nas faixas: 10 a 14, 15 a 19, 20 a 34, 35 a 39, 40 anos e mais. IDADEMAE 99, 0 ou em branco = "Ignorado", apresentado como categoria própria (decisão da coordenação, 09/09/2026).
Distribuição percentual dos nascidos vivos por raça/cor da mãe	Total de nascidos vivos em cada categoria de raça/cor da mãe, dividido pelo total de nascidos vivos e multiplicado por 100.	Fonte: SINASC. RACACORMAE: 1 Branca, 2 Preta, 3 Amarela, 4 Parda, 5 Indígena. Campo em branco = "Ignorado", apresentado como categoria própria (a Declaração de Nascido Vivo não tem a opção "ignorado"). Variável autodeclarada, disponível desde 2010.
Distribuição percentual dos nascidos vivos por escolaridade da mãe	Total de nascidos vivos em cada categoria de escolaridade da mãe, dividido pelo total de nascidos vivos e multiplicado por 100.	Fonte: SINASC. ESCMAE (anos de estudo concluídos; desde 2010 derivada pelo SINASC de ESCMAE2010 e SERIESCMAE): "Até 3 anos" = ESCMAE 1 (nenhuma) ou 2 (1 a 3 anos); "4 a 7 anos" = 3; "8 a 11 anos" = 4; "12 anos e mais" = 5. ESCMAE 9 ou em branco = "Ignorado", categoria própria. O código 0 pertence a ESCMAE2010 e não é usado.
Distribuição percentual dos nascidos vivos por situação conjugal da mãe	Total de nascidos vivos em cada categoria de situação conjugal da mãe, dividido pelo total de nascidos vivos e multiplicado por 100.	Fonte: SINASC. ESTCIVMAE: 1 solteira, 3 viúva, 4 separada judicialmente/divorciada = "Solteira, viúva ou separada"; 2 casada, 5 união estável = "Casada ou em união estável" (rótulo oficial do código 5: união estável). ESTCIVMAE 9 ou em branco = "Ignorado", categoria própria.

Perfil obstétrico (SINASC)

Tabela 9 – Perfil obstétrico (SINASC): indicadores e regras

Indicador	O que mede	Variáveis e regra
Distribuição percentual dos nascidos vivos por número de gestações anteriores da mãe	Total de nascidos vivos de mães em cada faixa de número de gestações anteriores, dividido pelo total de nascidos vivos e multiplicado por 100.	Fonte: SINASC. QTDGESTANT (número de gestações anteriores; inclui as gestações interrompidas), nas faixas: "Nenhuma", "De 1 a 3", "De 4 a 6", "De 7 a 9", "10 ou mais". QTDGESTANT 99 ou em branco = "Ignorado", categoria própria. Título alterado de "partos anteriores" para "gestações anteriores" (decisão da coordenação, 09/09/2026): a variável QTDGESTANT conta gestações. O rótulo será atualizado em conjunto na planilha, no painel e nas apresentações.
Distribuição percentual dos nascidos vivos por número de cesarianas anteriores da mãe	Total de nascidos vivos de mães em cada faixa de número de cesarianas anteriores, dividido pelo total de nascidos vivos e multiplicado por 100.	Fonte: SINASC. QTDPARTCES (número de cesarianas anteriores), nas faixas: "Nenhuma", "De 1 a 3", "De 4 a 6", "De 7 a 9", "10 ou mais". QTDPARTCES 99 ou em branco = "Ignorado", categoria própria. Observação: a literatura costuma usar 1, 2 e 3 ou mais; as faixas acima foram mantidas por padronização com a planilha.
Distribuição percentual dos nascidos vivos por tipo de gestação	Total de nascidos vivos com cada tipo de gestação, dividido pelo total de nascidos vivos e multiplicado por 100.	Fonte: SINASC. GRAVIDEZ: 1 Única, 2 Dupla, 3 Tripla ou mais. GRAVIDEZ 9 ou em branco = "Ignorado", categoria própria.

Porcentagem de mães de nascidos vivos com número adequado de consultas para a idade gestacional no parto	Proporção de nascidos vivos cujas mães tiveram número de consultas de pré-natal igual ou superior ao mínimo esperado para a idade gestacional no parto, segundo o calendário de 8 contatos da OMS (2016).	Fonte: SINASC. Referência: OMS, Recomendações sobre cuidados pré-natais para uma experiência positiva na gravidez (2016): contatos em até 12, 20, 26, 30, 34, 36, 38 e 40 semanas. Mínimo de consultas por idade gestacional no parto (SEMAGESTAC): menos de 20 semanas = 1; 20 a 25 = 2; 26 a 29 = 3; 30 a 33 = 4; 34 a 35 = 5; 36 a 37 = 6; 38 a 39 = 7; 40 ou mais = 8. Adequado = CONSPRENAT maior ou igual ao mínimo. CONSPRENAT 99 ou em branco, ou SEMAGESTAC 99 ou em branco = "Ignorado", categoria própria, fora do denominador (correção aprovada; a regra anterior tratava o 99 como valor válido — decisão da coordenação, 09/09/2026).

4.5 Tabelas do dossiê (blocos de nascidos vivos)

As tabelas do dossiê reproduzem a apresentação de cada maternidade. As categorias de cada tabela seguem as variáveis da Declaração de Nascido Vivo, conforme a Estrutura do SINASC (Ministério da Saúde, versão de 22/02/2024), e as faixas adotadas nas apresentações oficiais das maternidades. A tabela abaixo resume a variável do SINASC e as categorias de cada bloco.

Tabela 10 – Variáveis e categorias das tabelas do dossiê de nascimentos

Tabela do dossiê	Variável do SINASC	Categorias
Nascidos vivos e território (ocorrência e residência)	CODESTAB, CODMUNNASC, CODMUNRES	Totais por município, região de saúde, macrorregião e UF de ocorrência e de residência, para todos os nascidos vivos e para os de menos de 1.500 g (fichas na seção 4.3).
Residência da mãe por região do país e UF	CODMUNRES	Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste; UF de residência.
Consultas de pré-natal	CONSULTAS	Nenhuma; 1 a 3 consultas; 4 a 6 consultas; 7 e mais consultas; Ignorado.
Trimestre de início do pré-natal	MESPRENAT (mês de início, 01 a 09)	Primeiro trimestre (meses 1 a 3); Segundo (4 a 6); Terceiro (7 em diante); Ignorado (99 ou em branco).
Peso ao nascer	PESO (gramas)	0 a 999 g; 1.000 a 1.499 g; 1.500 a 2.499 g; 2.500 a 2.999 g; 3.000 a 3.999 g; 4.000 g e mais; peso inválido ou em branco não entra na tabela.
Idade gestacional	GESTACAO (faixas)	Menos de 22 semanas; 22 a 27; 28 a 31; 32 a 36; 37 a 41; 42 e mais; "N Inf" (não informada).
Via de nascimento	PARTO	Parto vaginal (1); Cesárea (2); Ignorado (demais valores).
Assistência ao parto vaginal	TPNASCASSI, entre os partos vaginais	Médico (1); Enfermeira ou obstetriz (2); Parteira (3); Outros (4); Ignorado (demais valores).
Apgar no 5º minuto	APGAR5, entre nascidos com 2.500 g ou mais e sem anomalia congênita (IDANOMAL diferente de 1)	0 a 3; 4 a 6; 7 a 10; "Ign" (código 99); "N Inf" (em branco).
Grupos de Robson (número de nascidos vivos e taxa de cesárea por grupo)	TPROBSON e PARTO	Grupo 1 a Grupo 10 (códigos 01 a 10); Não classificados (demais valores; nos registros das unidades, o código 11); Total (seção 4.6).

Linhas de percentual nas apresentações. Nas apresentações de cada maternidade, as linhas de percentual das tabelas de pré-natal, peso, idade gestacional, via de nascimento e assistência ao parto são calculadas sobre o total da tabela, incluindo os registros ignorados; a linha "% Primeiro Trimestre" usa o total da tabela de trimestre, incluindo os ignorados. Os indicadores dos mapas e do comparador (seção 4.2) excluem os ignorados do denominador. Por isso um mesmo indicador pode diferir alguns décimos entre a apresentação e o mapa.

4.6 Grupos de Robson

A classificação de Robson separa todas as mulheres que dão à luz em dez grupos, mutuamente exclusivos e que cobrem todos os casos, com base em paridade, cesárea anterior, início do trabalho de parto, apresentação fetal, número de fetos e idade gestacional. A Organização Mundial da Saúde (OMS) a recomenda como instrumento padrão para avaliar, monitorar e comparar taxas de cesárea. As definições abaixo são as da versão em português da Declaração da OMS sobre Taxas de Cesáreas (2015, Quadro 1).

Tabela 11 – Grupos de Robson: definições da OMS (2015) e valores de referência do manual de implementação da OMS (2017)

Grupo	Definição (OMS, 2015)	Referência de taxa de cesárea (OMS, 2017, Tabela 8)
Grupo 1	Nulíparas com feto único, cefálico, 37 semanas ou mais, em trabalho de parto espontâneo.	Taxas abaixo de 10% são alcançáveis. O painel usa até 10%.
Grupo 2	Nulíparas com feto único, cefálico, 37 semanas ou mais, cujo parto é induzido ou que são submetidas à cesárea antes do início do trabalho de parto.	Consistentemente em torno de 20% a 35%. O painel usa até 35%.
Grupo 3	Multíparas sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, 37 semanas ou mais, em trabalho de parto espontâneo.	Normalmente não mais que 3,0%. O painel usa até 3%.
Grupo 4	Multíparas sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, 37 semanas ou mais, cujo parto é induzido ou que são submetidas à cesárea antes do início do trabalho de parto.	Raramente deve ser maior que 15%. O painel usa até 15%.
Grupo 5	Todas as multíparas com pelo menos uma cesárea anterior, com feto único, cefálico, 37 semanas ou mais.	Taxas de 50% a 60% são consideradas apropriadas, desde que com bons desfechos maternos e perinatais. O painel não fixa referência.
Grupo 6	Todas as nulíparas com feto único em apresentação pélvica.	Sem referência de taxa na Tabela 8.
Grupo 7	Todas as multíparas com feto único em apresentação pélvica, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).	Sem referência de taxa na Tabela 8.
Grupo 8	Todas as mulheres com gestação múltipla, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).	Em geral em torno de 60%. O tamanho do grupo costuma ser de 1,5% a 2%.
Grupo 9	Todas as gestantes com feto em situação transversa ou oblíqua, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).	Deve ser 100% por convenção; o tamanho do grupo deve ser menor que 1%.
Grupo 10	Todas as gestantes com feto único e cefálico, com menos de 37 semanas, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).	Em geral em torno de 30%; o tamanho do grupo costuma ser menor que 5% em populações de risco habitual.

O manual da OMS acrescenta que os grupos 1, 2 e 5, somados, costumam responder por cerca de dois terços de todas as cesáreas de um hospital, e que a tabela de Robson deve registrar à parte os casos não classificáveis. Os valores de referência dos grupos 1 a 4 usados no painel coincidem com os limites superiores do manual; o painel os apresenta como "meta".

Como o SINASC classifica. O campo TPROBSON da Declaração de Nascido Vivo é o "código do Grupo de Robson, gerado pelo sistema" (Estrutura do SINASC, OpenDataSUS, versão de 22/02/2024). O documento oficial não lista os valores. Nos registros das unidades dos painéis (2024 e 2025), aparecem os códigos 01 a 10 e 11; a extração trata 01 a 10 como os grupos e os demais valores como "Não classificados", que é a linha correspondente aos casos não classificáveis da tabela da OMS.

Duas observações de leitura. Primeira: o SINASC registra nascidos vivos, não mulheres; na gestação múltipla (grupo 8), cada nascido vivo conta uma vez, enquanto a tabela da OMS conta mulheres. Segunda: no grupo 9 (situação transversa ou oblíqua), a OMS espera 100% de cesárea por convenção; valores diferentes de 100% em unidades com poucos casos indicam registro de via de parto a conferir.

5. Dicionário do Painel de Internação (SIH/SUS)

As regras desta seção são as do Dicionário de indicadores de internação (AIH) do grupo de maternidades, versão final de 10/09/2026. Essa versão consolida as decisões da coordenação tomadas entre 30 de agosto e 9 de setembro de 2026 e substitui as versões anteriores, de 2 e de 7 de setembro de 2026. É a versão aplicada aos indicadores publicados no painel e nas apresentações de setembro de 2026.

Convenções: SIH-RD é o arquivo da AIH reduzida (um registro por internação) e SIH-SP é o arquivo de serviços profissionais (um registro por procedimento ou ato realizado na internação). Nomes em letras maiúsculas, como PROC_REA e DIAG_PRINC, são os nomes dos campos nos arquivos do DATASUS. O "universo obstétrico" é definido na primeira linha da tabela e serve de denominador para vários indicadores. PROC_REA é o procedimento realizado; DIAG_PRINC, DIAG_SECUN (preenchido até 2014) e DIAGSEC1 a DIAGSEC9 são os campos de diagnóstico; COBRANCA é o motivo de saída da AIH.

Internações obstétricas

Tabela 12 – Internações obstétricas: indicadores e regras

Indicador	O que mede	Variáveis e regra
Número de internações obstétricas	Total de internações de mulheres de 10 a 59 anos com diagnóstico do capítulo XV da CID-10 (O00 a O99) em qualquer campo de diagnóstico da AIH.	Fonte: SIH-RD (AIH reduzida), todas as competências disponíveis; ano de referência pela data de internação (DT_INTER). Universo obstétrico (decisão da coordenação, 09/09/2026): SEXO feminino, COD_IDADE = 4 e IDADE de 10 a 59 anos, com código O00 a O99 em qualquer campo de diagnóstico (DIAG_PRINC, DIAG_SECUN [preenchido até 2014], DIAGSEC1 a DIAGSEC9). Observação: nas 114 unidades, em 2019-2025, não há AIH de longa permanência (IDENT = 5) no recorte (conferido no microdado); cada AIH corresponde a um episódio de internação.
Distribuição percentual das internações obstétricas por motivos de internação (parto, aborto e intercorrências clínicas)	Proporção das internações obstétricas por motivo: Parto, Aborto, Intercorrências Clínicas e Outros.	Fonte: SIH-RD. Denominador: universo obstétrico (mulheres de 10 a 59 anos). GRUPO_INT_OBST pela variável PROC_REA: Aborto: 0409060070 (AMIU), 0411020013 (curetagem pós-abortamento/puerperal). Parto — vaginal: 0310010039, 0310010047, 0310010055 e 0409060313 (laqueadura tubária na mesma internação do parto normal; Portaria SAES/MS 1.549/2024, vigente desde a competência 04/2024; decisão da coordenação, 09/09/2026: é parto vaginal em todas as listas); cesariana: 0411010026, 0411010034, 0411010042. Intercorrências Clínicas: 0303100010, 0303100028, 0303100036, 0303100044, 0303100052, 0409060011, 0409060046, 0411010018, 0411010050, 0411010069, 0411010077, 0411010085, 0411020021, 0411020030, 0411020048, 0411020056 (vigente até 12/2018). Outros: demais procedimentos. A curetagem semiótica (0409060046) permanece aqui apenas como motivo de internação; ela não entra no indicador de AMIU.

Distribuição percentual das internações obstétricas por tipo de saída (alta, transferência e óbito)	Proporção das internações obstétricas por desfecho registrado na AIH.	Fonte: SIH-RD. Denominador: universo obstétrico. Classificação pelo primeiro dígito de COBRANCA (motivo de saída/permanência; Portaria SAS/MS 719/2007; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS 2017, item 6.3): 1x = Alta; 2x = Permanência; 3x = Transferência; 4x = Óbito; 51 = Encerramento administrativo. Códigos 6x (desfecho conjunto mãe/recém-nascido, exclusivos de AIH de parto; Portaria SAS/MS 384/2010): 61, 62, 63 e 64 = Alta da mãe (64 = alta da mãe com óbito fetal); 65, 66 e 67 = Óbito da mãe (65 = óbito da gestante e do concepto). Registrar à parte a frequência de 64 e 65. Indicador mantido na planilha; retirado das apresentações por decisão da coordenação (31/08/2026).
Número de internações obstétricas para interrupção da gestação em casos previstos por lei	Total de internações para interrupção da gestação nos casos previstos em lei (CID O04) com procedimento de esvaziamento uterino.	Fonte: SIH-RD. ABORTO_LEGAL = 1 quando o motivo de internação é Aborto (PROC_REA 0409060070 ou 0411020013) e há O04 em qualquer campo de diagnóstico. Operacionalização alinhada a Jacobs e Boing (2021). Limitações: O04 inclui aborto terapêutico; interrupções medicamentosas sem esvaziamento instrumental podem não ser captadas.
Porcentagem de AMIU dentre procedimentos de esvaziamento uterino	Total de AMIU dividido pelo total de esvaziamentos uterinos pós-abortamento, multiplicado por 100. Quanto maior, melhor (Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento, MS 2014).	Fonte: SIH-RD, sobre todas as AIH da unidade. Numerador: PROC_REA = 0409060070 (AMIU). Denominador: PROC_REA em 0409060070 ou 0411020013. A curetagem semiótica (0409060046) NÃO entra no denominador: no SIGTAP ela só tem CIDs ginecológicos e não é esvaziamento pós-abortamento (decisão da coordenação, 09/09/2026).
Porcentagem de internações que resultaram em parto com presença de acompanhante	Proporção de internações por parto com registro de diária de acompanhante na AIH (proxy da presença de acompanhante, Lei 11.108/2005).	Fonte: SIH-RD, sobre todas as AIH da unidade. Numerador: PROC_REA em 0310010039, 0310010047, 0310010055, 0409060313, 0411010026, 0411010034 ou 0411010042, com DIAR_ACOM > 0. Denominador: as mesmas AIH, sem a condição de acompanhante. Base: Lei 11.108/2005; Portaria GM/MS 2.418/2005 (autoriza a cobrança das despesas com acompanhante na AIH); Portaria GM/MS 1.459/2011, art. 7º. Limitação: DIAR_ACOM registra diárias faturadas, não a presença durante o trabalho de parto.

Porcentagem de internações para assistência ao parto vaginal com presença de acompanhante	Proporção de internações por parto vaginal com registro de diária de acompanhante.	Como no indicador anterior, restrito aos partos vaginais: 0310010039, 0310010047, 0310010055 e 0409060313 (incluído — decisão da coordenação, 09/09/2026).
Porcentagem de internações para cesariana com presença de acompanhante	Proporção de internações por cesariana com registro de diária de acompanhante.	Como no indicador de parto com acompanhante, restrito às cesarianas: 0411010026, 0411010034, 0411010042.
Porcentagem de internações para aborto com presença de acompanhante	Proporção de internações para interrupção da gestação nos casos previstos em lei com registro de diária de acompanhante.	Fonte: SIH-RD. Numerador: ABORTO_LEGAL = 1 com DIAR_ACOM > 0. Denominador: ABORTO_LEGAL = 1. Correções (decisão da coordenação, 09/09/2026): retirada a curetagem semiótica (0409060046) e corrigida a descrição anterior, que dizia "dividido pelo total de internações por parto". Nota: a Lei 11.108/2005 assegura acompanhante à parturiente; para o abortamento, o indicador mede prática de registro.
Número de partos em Centro de Parto Normal	Número de partos registrados com o procedimento específico de Centro de Parto Normal.	Fonte: SIH-RD, sobre todas as AIH da unidade. PROC_REA = 0310010055 (Portaria GM/MS 11/2015, art. 51: o procedimento registra as ações do CPN). Limitações: partos realizados em CPN e faturados como 0310010039 não são captados; unidade sem habilitação de CPN registra zero.
Taxa de Ocupação	Dias de permanência das internações obstétricas divididos pelos leitos-dia obstétricos do ano, multiplicado por 100.	Fonte: SIH-RD e CNES-LT. Numerador: soma de DIAS_PERM das internações do universo obstétrico, por ano de internação. Denominador: leitos-dia do ano — soma, nas 12 competências, de leitos obstétricos EXISTENTES (QT_EXIST, CODLEITO 10 e 43) × dias do mês —, normalizado para ano de 365 dias (em anos bissextos, ajuste 365/366). Limitação (nota técnica do DATASUS): DIAS_PERM inclui dias de UTI; a taxa pode exceder 100% em unidades superlotadas. Referências: Portaria SAS/MS 312/2002; ANS QUALISS E-EFI-02.

Tempo médio de permanência (geral, parto vaginal, cesariana, aborto, intercorrências clínicas)	Soma dos dias de permanência dividida pelo número de internações, no total e por motivo de internação.	Fonte: SIH-RD. Universo obstétrico. TMP = soma de DIAS_PERM / número de AIH, no geral e por grupo (Parto Vaginal, Cesariana, Aborto, Intercorrências Clínicas), com os mesmos códigos do indicador de motivos (0409060313 incluído em parto vaginal). DIAS_PERM = DT_SAIDA − DT_INTER (internação e alta no mesmo dia = 0). Referência do MS para obstetrícia: 2,4 a 3,1 dias.

Assistência ao parto

Tabela 13 – Assistência ao parto: indicadores e regras

Indicador	O que mede	Variáveis e regra
Porcentagem de nascidos vivos por partos vaginais pós-cesariana	Proporção de nascidos vivos por via vaginal entre mulheres com cesariana anterior (VBAC). Não é a taxa de sucesso da prova de trabalho de parto.	Fonte: SINASC. Numerador: PARTO = 1 (vaginal) e QTDPARTCES entre 1 e 98. Denominador: QTDPARTCES entre 1 e 98 e PARTO em 1 ou 2. QTDPARTCES 99 ou em branco e PARTO 9 ficam fora do cálculo (a regra anterior, QTDPARTCES > 0, incluía o 99).
Porcentagem de realização de analgesia em internações para partos vaginais	Total de internações para parto vaginal com registro de analgesia, dividido pelo total de internações para parto vaginal e multiplicado por 100.	Fonte: SIH-RD e SIH-SP. Numerador: AIH do denominador com pelo menos um registro SP_ATOPROF = 0417010028 (analgesia obstétrica para parto normal) na base SIH-SP. Denominador: PROC_REA em 0310010039, 0310010047, 0310010055 ou 0409060313. Nota: 0417010028 só existe em SP_ATOPROF e, no SIGTAP, é incompatível com 0310010055 (CPN); partos em CPN não terão o ato registrado.
Porcentagem de nascidos vivos com trabalho de parto induzido	Total de nascidos vivos com trabalho de parto induzido, dividido pelo total de nascidos vivos e multiplicado por 100.	Fonte: SINASC. Numerador: STTRABPART = 1. Denominador: total de nascidos vivos.

Internações neonatais

Tabela 14 – Internações neonatais: indicadores e regras

Indicador	O que mede	Variáveis e regra
Número de internações neonatais	Internações (AIH próprias) de recém-nascidos com 0 a 27 dias de vida na data da internação (período neonatal, OMS).	Fonte: SIH-RD; ano pela data de internação. NEO = 1 quando COD_IDADE ≤ 2 e IDADE entre 0 e 27 (idade em dias; o código 0, idade não exigida, ocorre raramente e foi mantido por compatibilidade com a tabulação de referência). Nota: o SIH só emite AIH própria para o recém-nascido internado separadamente da mãe (UTIN, permanência após a alta materna etc.); RN sadios em alojamento conjunto não são contados.
Porcentagem de internações neonatais em UTI neonatal	Proporção das internações neonatais com uso de UTI neonatal.	Fonte: SIH-RD. Numerador: NEO = 1 com MARCA_UTI 81 ou 82 (UTI neonatal tipos II e III; Portaria GM/MS 930/2012, art. 12, parágrafo único, e Portaria GM/MS 2.862/2023, art. 146). Denominador: NEO = 1. Nota: MARCA_UTI registra um único tipo de UTI por AIH; uso de UTI pediátrica ou de UCIN não é computado.
Distribuição percentual das internações neonatais por tipo de saída (alta, transferência e óbito)	Proporção das internações neonatais por desfecho registrado na AIH.	Fonte: SIH-RD. Denominador: NEO = 1 (denominador corrigido; o texto anterior dizia OBST = 1). Classificação pelo primeiro dígito de COBRANCA (Portaria SAS/MS 719/2007; Manual Técnico Operacional do SIH/SUS 2017, item 6.3): 1x = Alta; 2x = Permanência; 3x = Transferência; 4x = Óbito; 51 = Encerramento administrativo. Indicador mantido na planilha; retirado das apresentações por decisão da coordenação (31/08/2026).
Tempo médio de permanência em UTI neonatal (todas as AIH com uso de UTIN)	Média de diárias de UTIN por AIH com uso de UTIN, todas as idades.	Fonte: SIH-RD. Soma de UTI_MES_TO dividida pelo número de AIH com MARCA_UTI 81 ou 82 e UTI_MES_TO > 0, sem filtro de idade (Portaria SAS/MS 312/2002: estatísticas de unidade incluem todos os pacientes que passaram por ela).
Taxa de Ocupação	Total de diárias de UTIN dividido pelos leitos-dia de UTIN do ano, multiplicado por 100.	Fonte: SIH-RD e CNES-LT. Numerador: soma de UTI_MES_TO das AIH com MARCA_UTI 81 ou 82, todas as idades, por ano de internação. Denominador: leitos-dia de UTIN — leitos EXISTENTES (QT_EXIST, CODLEITO 81 e 82) por competência × dias do mês —, normalizado para ano de 365 dias. Regra transitória aprovada pela coordenação (05/09/2026): o CODLEITO 80 (UTI neonatal tipo I) entra apenas nas competências em que a unidade não tem nenhum leito 81/82 (coerente com a Portaria SAES/MS 2.902/2025, que reclassificou os leitos tipo I).

Morbidade materna

Tabela 15 – Morbidade materna: indicadores e regras

Indicador	O que mede	Variáveis e regra
Porcentagem de casos de morbidade materna grave (condições potencialmente ameaçadoras à vida, OMS)	Proporção de internações obstétricas com pelo menos uma condição potencialmente ameaçadora à vida (CPAV), operacionalizada no SIH/SUS conforme o Painel de Vigilância da Saúde Materna do Observatório Obstétrico Brasileiro (OOBr; Domingues et al. 2024). Não corresponde a near miss materno.	Fonte: SIH-RD e SIH-SP. Critério reescrito conforme o script do OOBr (decisão da coordenação, 09/09/2026), aplicado sobre o universo obstétrico da planilha (mulheres de 10 a 59 anos). Denominador: universo obstétrico. Caso = internação do universo com pelo menos um dos critérios: 1. CID (qualquer campo de diagnóstico): descolamento prematuro de placenta O450, O458, O459; gravidez ectópica O000 a O002, O008, O009; hemorragia pós-parto O720 a O722; rotura uterina O710, O711; pré-eclâmpsia grave O141; eclâmpsia O150 a O152, O159; hipertensão grave O11, O13, O149, O16, O100 a O104, O109, I10 a I15; encefalopatia hipertensiva I674; endometrite O85; edema pulmonar J81; insuficiência respiratória J80, J960, J969, R092, I26x, O032, O037, O042, O047, O052, O057, O062, O067, O072, O077, O082, O880 a O883, O888; convulsões R568; sepse A40x, A41x, A021, A227, A267, A327, A427, B377, O080, O753, O85; choque E86, R570, R571, R578, R579, T811, I460, O083, O751; crise tireotóxica E055; transfusão Z513; histerectomia O822; intubação O29x, O74x, O89x (decisão da coordenação, 09/09/2026). 2. Procedimento (PROC_REA) ou ato profissional (SP_ATOPROF) correspondente aos critérios: hipertensão grave, choque, transfusão, acesso venoso central, histerectomia, diárias de UTI, cirurgias, e ainda 0411020048 (ectópica), 0409060160 (rotura), 0303100028 (eclâmpsia), 0303040211 (encefalopatia), 0303060131 (edema agudo), 0303060140 (insuficiência respiratória). 3. Admissão à UTI: UTI_MES_TO > 0, diária de UTI (0802010083, 0802010091, 0802010105, 0802010296, 0802010318) ou ato de UTI na base SP. 4. Intervenção cirúrgica: procedimentos da lista do OOBr; curetagem 0411020013 apenas em episódio de parto ou com intercorrência puerperal (PROC_REA 0303100010 ou diagnóstico principal O70 a O94). 5. Tempo de permanência maior que 7 dias (DT_SAIDA − DT_INTER) apenas em internações de parto (lista de partos do OOBr, incluído o 0409060313), excluindo AIH com diária de acompanhante 0802010024. Limitações de registro no SIH: Nakamura-Pereira et al. 2013; Domingues et al. 2024.

Distribuição percentual dos casos de morbidade materna grave por grupo de causa	Porcentagem dos casos de MMG com diagnóstico em cada grupo de causa. Classificação não exclusiva: uma internação pode estar em mais de um grupo e a soma pode passar de 100.	Fonte: SIH-RD. Grupos marcados sobre os CASOS de MMG (critério OOBr acima), pelos códigos em qualquer campo de diagnóstico — os 7 grupos do modelo foram MANTIDOS por decisão da coordenação (09/09/2026): Causas obstétricas indiretas: O98 a O99. Complicações tromboembólicas: O880 a O883, O888; I26. Hipertensão: O10 a O16. Hemorragia: O00 a O08, O20 a O21, O44 a O46, O67, O72. Infecção: O23, O753, O85, O86, O98. Outras causas obstétricas: O09 a O19, O24 a O43, O47 a O71, O73 a O84, O87 a O92, O94 a O99, excluídos os códigos já alocados nos grupos anteriores. Demais causas: pelo menos um diagnóstico fora do capítulo XV (código não iniciado em O).
Porcentagem de casos de morbidade materna grave com internação em UTI	Proporção dos casos de MMG com admissão à UTI.	Fonte: SIH-RD e SIH-SP. Numerador: casos de MMG com UTI_MES_TO > 0, diária de UTI (0802010083, 0802010091, 0802010105, 0802010296, 0802010318) ou ato de UTI na base SP. Denominador: casos de MMG.
Porcentagem de casos de morbidade materna grave com tempo de permanência prolongado pós-parto	Proporção dos casos de MMG, em internações de parto, com permanência maior que 7 dias.	Fonte: SIH-RD e SIH-SP. Numerador: casos de MMG em internação de parto (lista do OOBr, incluído o 0409060313) com DT_SAIDA − DT_INTER maior que 7 dias, excluindo AIH com diária de acompanhante 0802010024 (na RD ou na SP). Denominador: casos de MMG.
Porcentagem de casos de morbidade materna grave com transfusão sanguínea	Proporção dos casos de MMG com registro de transfusão.	Fonte: SIH-RD e SIH-SP. Numerador: casos de MMG com Z513 em qualquer campo de diagnóstico, procedimento de transfusão ou ato de transfusão na base SP (0306020068, 0306020076, 0306020084, 0306020092, 0306020106, 0306020114, 0306020122, 0306020130, 0306020149). Denominador: casos de MMG. Nota: registro no SIH em torno de 50% (Domingues et al. 2024).
Porcentagem de casos de morbidade materna grave com realização de histerectomia	Proporção dos casos de MMG com histerectomia.	Fonte: SIH-RD e SIH-SP. Numerador: casos de MMG com O822 em qualquer campo de diagnóstico ou procedimento/ato em 0411020030, 0409060100, 0409060119, 0409060127, 0409060135. Denominador: casos de MMG. Nota: registro no SIH em torno de 36% (Domingues et al. 2024).

Morbidade neonatal

Tabela 16 – Morbidade neonatal: indicadores e regras

Indicador	O que mede	Variáveis e regra
Porcentagem de nascidos vivos com condições potencialmente ameaçadoras à vida	Proporção de nascidos vivos com pelo menos um critério pragmático de morbidade neonatal grave: peso ao nascer menor que 1.500 g, idade gestacional menor que 32 semanas ou Apgar no 5º minuto menor que 7 (Pileggi et al. 2010; Silva et al. 2014; Kale et al. 2017).	Fonte: SINASC. Numerador: PESO < 1500 (excluídos 0, 9999 e em branco), OU idade gestacional menor que 32 semanas (SEMAGESTAC < 32; se ignorada, GESTACAO 1, 2 ou 3), OU APGAR5 < 7 (excluídos valores fora de 0 a 10 e em branco). Denominador: total de nascidos vivos. Evitar rotular Apgar < 7 como "asfixia" (o manual da DN classifica 5 a 7 como asfixia leve).
Distribuição percentual das internações neonatais por grupos de causas	Distribuição das internações neonatais por grupo de causa, classificação EXCLUSIVA pelo diagnóstico principal da AIH: cada internação entra em um único grupo e a soma é 100 (decisão da coordenação, 09/09/2026).	Fonte: SIH-RD. Denominador: NEO = 1. Grupo pelo DIAG_PRINC, na ordem: Asfixia/Hipóxia P20 a P21; Infecções perinatais P35 a P39; Transtornos cardiovasculares perinatais P29; Afecções respiratórias do RN P22 a P28; Condições relacionadas a fatores maternos P00 a P04; Prematuridade e baixo peso ao nascer P07; Transtornos metabólicos e endócrinos P70 a P74; Anomalias congênitas Q00 a Q99; Causas mal definidas R00 a R99; Outras afecções do período perinatal = demais códigos P00 a P96; Demais causas = diagnóstico principal fora dos grupos anteriores. Motivo da mudança: com a marcação em qualquer campo de diagnóstico, a soma passava de 100 (uma internação entrava em vários grupos); pelo diagnóstico principal a distribuição soma 100.

5.1 Comparador e destaques

No comparador do Painel de Internação, a média do grupo é a média simples das unidades do grupo com dados no ano, e o destaque segue a regra descrita na seção 3.2. Os valores publicados referem-se às 114 unidades calculadas em 9 de setembro de 2026 e às unidades incluídas posteriormente (Pernambuco, em 12 de setembro; Maranhão, Ceará e São Paulo, em 23 de setembro de 2026).

6. Dicionário do Painel de Mortalidade (SIM)

As regras desta seção são as do Dicionário de indicadores de mortalidade do grupo de maternidades, versão de 11/09/2026. O dicionário descreve os indicadores publicados no painel e nas apresentações por maternidade, calculados em 11 de setembro de 2026 segundo as seguintes regras: óbito materno pela definição do Ministério da Saúde; Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções do SUS (LBE), na versão de tabulação para menores de 5 anos do DATASUS e da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS); e recuperação da idade neonatal pelo campo IDADE da Declaração de Óbito.

Convenções: SIM-DO é o arquivo das declarações de óbito e SIM-DOFET, o das declarações de óbito fetal; nomes em letras maiúsculas são campos desses arquivos e da Declaração de Nascido Vivo; CODESTAB é o código CNES do estabelecimento de ocorrência e CAUSABAS é a causa básica do óbito. Referências citadas pelo dicionário: IDB/DATASUS, Indicadores e Dados Básicos, fichas C.1.1 (mortalidade neonatal precoce), C.1.2 (neonatal tardia), C.3 e Anexo I (razão de mortalidade materna e conceito de óbito materno) e C.5 (perinatal); Guia de Vigilância Epidemiológica do Óbito Materno (MS, 2009); Lista de Tabulação de Causas Evitáveis de menores de 5 anos (DATASUS/SVS; Malta et al., 2007 e 2010); dicionários de variáveis do SIM e do SINASC; painel Óbitos de Gestantes e Puérperas do Observatório Obstétrico Brasileiro (OOBr). Os códigos citados são da CID-10.

Definições gerais (SIM e SINASC)

Tabela 17 – Definições gerais (SIM e SINASC): indicadores e regras

Indicador	O que mede	Variáveis e regra
Unidade de análise e ano de referência	Óbitos atribuídos ao estabelecimento de saúde onde ocorreram e ao ano da data do óbito.	Fonte: SIM, arquivos DO (Declarações de Óbito) e DOFET (Declarações de Óbito Fetal). Estabelecimento: CODESTAB (código CNES do local de ocorrência, 7 dígitos, completado com zeros à esquerda). Ano: ano de DTOBITO (data do óbito, ddmmaaaa). Arquivos do DATASUS: DO<UF><ano>.dbc de 2019 a 2024 (definitivos), DO<UF>2025.dbc (preliminar) e DOFET<aa>.dbc de 2019 a 2025 (arquivo nacional). Todas as UFs são lidas, porque o óbito é contado na unidade onde ocorreu, independentemente da residência. Registros com CODESTAB em branco (óbitos em domicílio, via pública ou sem identificação do estabelecimento) não são atribuídos a nenhuma unidade. HCFAMEMA (Marília, SP): os CNES 2025507 (hospital adulto) e 2025523 (materno-infantil) são tratados como um único complexo: óbitos dos dois códigos e nascidos vivos do 2025523.
Nascidos vivos (denominador)	Total de nascidos vivos ocorridos no estabelecimento no ano.	Fonte: SINASC. Estabelecimento: CODESTAB = CNES da unidade. Ano: ano de DTNASC (data de nascimento). Arquivos DN<UF><ano>.dbc. Inclui todos os nascidos vivos ocorridos na unidade, independentemente do município de residência da mãe. É o denominador da razão de mortalidade materna e das taxas neonatais e compõe, com os óbitos fetais, o denominador das taxas fetal e perinatal.
Situação dos dados	Anos definitivos e preliminares da série 2019 a 2025.	Fonte: SIM e SINASC. 2019 a 2023: dados definitivos. 2024 e 2025: dados preliminares do DATASUS, sujeitos a revisão; extração de 10 e 11/09/2026. Totais de 2024 e 2025 podem diferir de tabulações feitas em outra data. As apresentações trazem a nota "dados sujeitos a revisão".

Mortalidade materna (SIM e SINASC)

Tabela 18 – Mortalidade materna (SIM e SINASC): indicadores e regras

Indicador	O que mede	Variáveis e regra
Número de óbitos maternos	Total de óbitos de mulheres durante a gestação ou até 42 dias após o seu término, por causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela, excluídas as causas acidentais ou incidentais (OMS, CID-10; IDB C.3, Anexo I).	Fonte: SIM-DO. Criada a variável OBITO_MATERNO = 1 quando SEXO = 2 (feminino; "F" nos arquivos preliminares) e a causa básica (CAUSABAS) atende a uma das três condições: (a) O00 a O95, O98 ou O99 (capítulo XV da CID-10, excluídos O96 e O97, óbitos maternos tardios): conta sempre; (b) A34 (tétano obstétrico), F53 (transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério) ou M83.0 (osteomalácia puerperal): conta quando OBITOPUERP = 1 ou ignorado; (c) B20 a B24 (doença pelo HIV), D39.2 (mola hidatiforme invasiva) ou E23.0 (hipopituitarismo, inclui a necrose hipofisária pós-parto): conta somente quando OBITOGRAV = 1 ou OBITOPUERP = 1. OBITOGRAV (campo 43 da DO, óbito na gravidez): 1 sim, 2 não, 9 ignorado; branco = 9. OBITOPUERP (campo 44, óbito no puerpério): 1 sim, até 42 dias; 2 sim, de 43 dias a 1 ano; 3 não; 9 ignorado; branco, 0, 4 e 8 = 9. Não há filtro de idade. Registros com OBITOGRAV e OBITOPUERP ignorados entram apenas pelas condições (a) e (b). Homens e óbitos com causa presumível sem confirmação do momento (condição c com campos ignorados) não entram: essa era a diferença da regra anterior, que contava todos os B20 a B24 com os campos em branco. Referência: IDB/DATASUS C.3, Anexo I; Guia de Vigilância Epidemiológica do Óbito Materno (MS, 2009); regra do painel OOBr.

Razão de Mortalidade Materna (RMM)	Número de óbitos maternos ocorridos na unidade, dividido pelo número de nascidos vivos ocorridos na unidade no mesmo ano e multiplicado por 100.000.	Fonte: SIM-DO e SINASC. Numerador: OBITO_MATERNO = 1, por CODESTAB e ano de DTOBITO. Denominador: nascidos vivos por CODESTAB e ano de DTNASC. Sem fator de correção (o IDB aplica fator de correção apenas aos agregados de UF e país). A RMM por estabelecimento de ocorrência não é comparável à RMM populacional (IDB C.3): o numerador inclui óbitos de mulheres cujo parto ocorreu em outro serviço ou que foram transferidas para a unidade, e o denominador contém apenas os partos da própria unidade. Em unidades com poucos nascidos vivos, um único óbito produz valores elevados; o número absoluto deve ser lido junto com a razão.
Distribuição dos óbitos maternos por tipo de causa obstétrica (diretas, indiretas e inespecíficas)	Número de óbitos maternos em cada tipo de causa obstétrica: direta, indireta ou não especificada.	Fonte: SIM-DO. Criada a variável TIPO_CAUSA a partir de CAUSABAS dos registros com OBITO_MATERNO = 1: "Direta" = O00 a O08, O11 a O23, O24.4, O26 a O92, A34, D39.2, E23.0, F53, M83.0; "Indireta" = O10, O24 (exceto O24.4), O25, O94, O98, O99, B20 a B24; "Inespecífica" = O95 (morte obstétrica de causa não especificada). O94 (sequelas de complicações da gravidez, parto e puerpério) é classificado como indireta, conforme o OOBr. Referência: CID-10, capítulo XV; Guia de Vigilância Epidemiológica do Óbito Materno (MS, 2009).
Distribuição dos óbitos maternos diretos por grupo de causas	Número de óbitos maternos por causas obstétricas diretas em cada grupo de causas, com o total de diretas.	Fonte: SIM-DO. Criada a variável GRUPO_DIRETA a partir de CAUSABAS dos registros com TIPO_CAUSA = "Direta", com precedência na ordem listada: "Aborto" = O00 a O08; "Hipertensão (pré-eclâmpsia/eclâmpsia)" = O11 a O16; "Hemorragia" = O20, O44, O45, O46, O67, O72; "Infecção puerperal" = O85, O86, O91; "Tromboembolismo" = O88; "Outras causas diretas" = demais causas diretas (O21 a O23, O24.4, O26 a O43, O47 a O66, O68 a O71, O73 a O84, O87, O89, O90, O92, A34, D39.2, E23.0, F53, M83.0). "Total diretas" = soma dos seis grupos = TIPO_CAUSA = "Direta". Grupo sem ocorrência é apresentado com zero. A tabela traz números absolutos; o percentual de cada grupo é calculado sobre o total de diretas.

Distribuição dos óbitos maternos indiretos por grupo de causas	Número de óbitos maternos por causas obstétricas indiretas em cada grupo de causas, com o total de indiretas.	Fonte: SIM-DO. Criada a variável GRUPO_INDIRETA a partir de CAUSABAS dos registros com TIPO_CAUSA = "Indireta": "Doenças infecciosas e parasitárias" = O98, B20 a B24; "Cardiopatias (O99.4)" = O99.4; "Doenças respiratórias (O99.5)" = O99.5; "Hipertensão/diabetes pré-existentes" = O10, O24 (exceto O24.4), O25; "Outras afecções maternas (O99)" = O99 (exceto O99.4 e O99.5), O94. "Total indiretas" = soma dos cinco grupos = TIPO_CAUSA = "Indireta". Óbitos com O95 (inespecífica) não entram nas tabelas de grupos; aparecem apenas na linha "Inespecíficas" do indicador anterior. Observação: O25 (desnutrição na gravidez) está agrupado com O10 e O24 por decisão do script original; o rótulo do grupo não o descreve. Recomenda-se renomear o grupo para "Doenças pré-existentes (hipertensão, diabetes e desnutrição)" ou mover O25 para "Outras afecções maternas".

Mortalidade fetal (SIM-DOFET e SINASC)

Tabela 19 – Mortalidade fetal (SIM-DOFET e SINASC): indicadores e regras

Indicador	O que mede	Variáveis e regra
Número de óbitos fetais	Total de óbitos fetais ocorridos na unidade no ano, com 22 semanas ou mais de gestação ou peso de 500 g ou mais.	Fonte: SIM-DOFET (declarações de óbito fetal; TIPOBITO = 1). Criada a variável OBITO_FETAL = 1 quando SEMAGESTAC ≥ 22 (valores válidos de 1 a 44 semanas) ou PESO ≥ 500 (valores válidos de 100 a 8.000 g). Não entram: registros com idade gestacional inferior a 22 semanas e peso inferior a 500 g; e registros com os dois campos ignorados (branco, 99 ou 9999, ou fora da faixa válida). Este segundo grupo é uma exclusão, não uma estimativa: o IDB recomenda incluir no numerador os óbitos fetais com idade gestacional ignorada. A opção adotada é conservadora e deve constar nas notas das apresentações. Estabelecimento: CODESTAB; ano: DTOBITO. Referência: IDB/DATASUS C.5; CID-10, volume 2 (limite de 22 semanas ou 500 g para as estatísticas perinatais nacionais); Portaria SVS/MS 116/2009 (a DO fetal é obrigatória a partir de 20 semanas, 500 g ou 25 cm, por isso o arquivo contém registros abaixo do limite estatístico).
Taxa de Mortalidade Fetal	Número de óbitos fetais dividido pelo total de nascimentos (nascidos vivos mais óbitos fetais) ocorridos na unidade no ano, multiplicado por 1.000.	Fonte: SIM-DOFET e SINASC. Numerador: OBITO_FETAL = 1. Denominador: nascidos vivos (SINASC, CODESTAB, ano de DTNASC) + OBITO_FETAL = 1. Referência: IDB C.5 (mesmo denominador da taxa de mortalidade perinatal). Taxa por estabelecimento de ocorrência: unidades de referência recebem gestantes com óbito fetal já diagnosticado, o que eleva a taxa em relação ao conjunto do território.
Distribuição percentual dos óbitos fetais por faixa de peso	Total de óbitos fetais em cada faixa de peso ao nascer, dividido pelo total de óbitos fetais e multiplicado por 100.	Fonte: SIM-DOFET. Criada a variável FAIXA_PESO a partir de PESO (gramas) com as seguintes categorias: "Menos de 1000g" (100 a 999), "1000g a 1499g", "1500g a 2499g", "2500g a 3999g", "4000g e mais" (4.000 a 8.000), "Ignorado / sem informação" (branco, 0, 9999 ou fora de 100 a 8.000). Denominador: OBITO_FETAL = 1. A linha Total soma 100%.

Distribuição percentual dos óbitos fetais por momento do óbito em relação ao parto	Total de óbitos fetais em cada momento do óbito (anteparto, intraparto), dividido pelo total de óbitos fetais e multiplicado por 100.	Fonte: SIM-DOFET. Categorização da variável OBITOPARTO (morte em relação ao parto): 1 = "Antes do parto (anteparto)", 2 = "Durante o parto (intraparto)", 3 = "Após o parto", 9 ou branco = "Ignorado / sem informação". O código 3 não se aplica a óbito fetal e indica erro de preenchimento; a linha "Após o parto" é omitida da apresentação quando é zero em todos os anos. Denominador: OBITO_FETAL = 1.
Distribuição percentual dos óbitos fetais por grupo de causas	Total de óbitos fetais em cada grupo de causa básica, dividido pelo total de óbitos fetais e multiplicado por 100.	Fonte: SIM-DOFET. Criada a variável GRUPO_CAUSA a partir de CAUSABAS (classificação própria, por faixas da CID-10, com precedência na ordem listada): "Feto/RN afetado por fatores maternos, placenta, cordão e membranas" = P00 a P04; "Transtornos ligados à gestação e crescimento fetal" = P05, P07, P08; "Hipóxia/asfixia e transtornos respiratórios" = P10 a P15, P20, P21, P24, P28; "Infecções específicas do período perinatal" = P35 a P39, A50; "Anomalias congênitas" = Q00 a Q99; "Transtornos hemorrágicos e hematológicos do feto/RN" = P50 a P61; "Causas mal definidas" = R00 a R99, P95 (morte fetal de causa não especificada); "Demais causas" = todos os outros códigos (inclui P22, P23, P25 a P27, P29, P70 a P94, P96 e causas fora dos capítulos XVI e XVII). Não existe lista oficial do Ministério da Saúde para este recorte; a classificação deve ser rotulada como própria (a OMS publica a ICD-PM para óbitos perinatais). Recomenda-se avaliar a inclusão de P22 (desconforto respiratório do recém-nascido) e P23 (pneumonia congênita) no grupo de hipóxia/asfixia e transtornos respiratórios, onde já estão P24 e P28. Denominador: OBITO_FETAL = 1.

Mortalidade perinatal (SIM-DOFET, SIM-DO e SINASC)

Tabela 20 – Mortalidade perinatal (SIM-DOFET, SIM-DO e SINASC): indicadores e regras

Indicador	O que mede	Variáveis e regra
Número de óbitos perinatais	Total de óbitos fetais (22 semanas ou mais, ou 500 g ou mais) mais óbitos de nascidos vivos com 0 a 6 dias completos de vida, ocorridos na unidade no ano.	Fonte: SIM-DOFET e SIM-DO. OBITO_PERINATAL = OBITO_FETAL = 1 (DOFET) ou OBITO_NEONATAL = 1 com IDADE_DIAS entre 0 e 6 (DO). As regras de OBITO_FETAL e IDADE_DIAS são as descritas nas seções de mortalidade fetal e neonatal. Referência: IDB/DATASUS C.5; CID-10 (período perinatal: de 22 semanas completas de gestação a 7 dias completos após o nascimento).
Taxa de Mortalidade Perinatal	Número de óbitos perinatais dividido pelo total de nascimentos (nascidos vivos mais óbitos fetais) ocorridos na unidade no ano, multiplicado por 1.000.	Fonte: SIM-DOFET, SIM-DO e SINASC. Numerador: OBITO_PERINATAL = 1. Denominador: nascidos vivos (SINASC, CODESTAB, ano de DTNASC) + OBITO_FETAL = 1. Referência: IDB C.5. Limitação: o componente neonatal precoce é atribuído pelo local do óbito, e a DO não informa o estabelecimento de nascimento; em maternidades com UTI neonatal, recém-nascidos nascidos em outro serviço entram no numerador sem entrar no denominador.
Distribuição percentual dos óbitos perinatais por faixa de peso	Total de óbitos perinatais em cada faixa de peso ao nascer, dividido pelo total de óbitos perinatais e multiplicado por 100.	Fonte: SIM-DOFET e SIM-DO. FAIXA_PESO a partir de PESO (peso ao nascer, em gramas, nas duas declarações), com as mesmas categorias do indicador fetal: "Menos de 1000g", "1000g a 1499g", "1500g a 2499g", "2500g a 3999g", "4000g e mais", "Ignorado / sem informação". Denominador: OBITO_PERINATAL = 1.
Distribuição percentual dos óbitos perinatais por momento do óbito (componente fetal e neonatal precoce)	Total de óbitos perinatais em cada componente (fetal ou neonatal precoce), dividido pelo total de óbitos perinatais e multiplicado por 100.	Fonte: SIM-DOFET e SIM-DO. "Fetal" = OBITO_FETAL = 1 (registro da DOFET); "Neonatal precoce" = óbito da DO com IDADE_DIAS entre 0 e 6. Denominador: OBITO_PERINATAL = 1.
Distribuição percentual dos óbitos perinatais por grupo de causas	Total de óbitos perinatais em cada grupo de causa básica, dividido pelo total de óbitos perinatais e multiplicado por 100.	Fonte: SIM-DOFET e SIM-DO. GRUPO_CAUSA a partir de CAUSABAS das duas declarações, com a mesma classificação própria do indicador fetal (P00 a P04; P05, P07, P08; P10 a P15, P20, P21, P24, P28; P35 a P39, A50; Q00 a Q99; P50 a P61; R00 a R99, P95; demais causas). Denominador: OBITO_PERINATAL = 1.

Mortalidade neonatal (SIM-DO e SINASC)

Tabela 21 – Mortalidade neonatal (SIM-DO e SINASC): indicadores e regras

Indicador	O que mede	Variáveis e regra
Número de óbitos neonatais (0 a 27 dias)	Total de óbitos de nascidos vivos com 0 a 27 dias completos de vida ocorridos na unidade no ano.	Fonte: SIM-DO. Criada a variável IDADE_DIAS = DTOBITO menos DTNASC, em dias. Quando DTNASC está em branco ou é inválida, IDADE_DIAS é recuperada do campo IDADE do SIM (3 dígitos: unidade + quantidade): unidade 0 (minutos) ou 1 (horas) = 0 dias; unidade 2 (dias) = quantidade; unidades 3 (meses), 4 e 5 (anos), 999 (ignorada) ou campo em branco = não neonatal. OBITO_NEONATAL = 1 quando IDADE_DIAS entre 0 e 27. Estabelecimento: CODESTAB; ano: DTOBITO. Sem filtro de peso ou idade gestacional. A recuperação pelo campo IDADE é a diferença em relação às planilhas anteriores, que descartavam os registros sem DTNASC; por isso alguns totais neonatais aumentaram de 1 a 3 óbitos. Referência: IDB/DATASUS C.1.1 e C.1.2.
Taxa de Mortalidade Neonatal	Número de óbitos neonatais (0 a 27 dias) dividido pelo número de nascidos vivos ocorridos na unidade no ano, multiplicado por 1.000.	Fonte: SIM-DO e SINASC. Numerador: OBITO_NEONATAL = 1. Denominador: nascidos vivos (SINASC, CODESTAB, ano de DTNASC). Limitação estrutural: o óbito é atribuído pelo local de ocorrência e a DO não informa o estabelecimento de nascimento. Em maternidades de referência com UTI neonatal, óbitos de recém-nascidos nascidos em outro serviço entram no numerador enquanto o denominador só tem os nascidos vivos da própria unidade, o que eleva a taxa. A taxa por estabelecimento não é comparável à taxa populacional do IDB.
Distribuição percentual dos óbitos neonatais por momento do óbito (dias de vida)	Total de óbitos neonatais em cada faixa de idade ao morrer (0 dias, 1 a 6 dias, 7 a 27 dias), dividido pelo total de óbitos neonatais e multiplicado por 100.	Fonte: SIM-DO. Categorização de IDADE_DIAS: "0 dias" = 0 (óbito nas primeiras 24 horas); "1-6 dias" = 1 a 6; "7-27 dias" = 7 a 27. Denominador: OBITO_NEONATAL = 1.
Número e Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (0 a 6 dias)	Total de óbitos de nascidos vivos com 0 a 6 dias completos de vida, e esse total dividido pelo número de nascidos vivos ocorridos na unidade no ano, multiplicado por 1.000.	Fonte: SIM-DO e SINASC. Numerador: OBITO_NEONATAL = 1 e IDADE_DIAS entre 0 e 6. Denominador: nascidos vivos. Referência: IDB C.1.1.

Número e Taxa de Mortalidade Neonatal Tardia (7 a 27 dias)	Total de óbitos de nascidos vivos com 7 a 27 dias completos de vida, e esse total dividido pelo número de nascidos vivos ocorridos na unidade no ano, multiplicado por 1.000.	Fonte: SIM-DO e SINASC. Numerador: OBITO_NEONATAL = 1 e IDADE_DIAS entre 7 e 27. Denominador: nascidos vivos. Referência: IDB C.1.2. Precoce + tardia = neonatal total.
Distribuição percentual dos óbitos neonatais por faixa de peso	Total de óbitos neonatais em cada faixa de peso ao nascer, dividido pelo total de óbitos neonatais e multiplicado por 100.	Fonte: SIM-DO. FAIXA_PESO a partir de PESO (peso ao nascer registrado na DO, em gramas), com as categorias "Menos de 1000g", "1000g a 1499g", "1500g a 2499g", "2500g a 3999g", "4000g e mais", "Ignorado / sem informação". Denominador: OBITO_NEONATAL = 1.
Distribuição percentual dos óbitos neonatais por grupo de causas	Total de óbitos neonatais em cada grupo de causa básica, dividido pelo total de óbitos neonatais e multiplicado por 100.	Fonte: SIM-DO. GRUPO_CAUSA a partir de CAUSABAS, com a mesma classificação própria dos indicadores fetal e perinatal (P00 a P04; P05, P07, P08; P10 a P15, P20, P21, P24, P28; P35 a P39, A50; Q00 a Q99; P50 a P61; R00 a R99, P95; demais causas). Denominador: OBITO_NEONATAL = 1.

Distribuição percentual dos óbitos neonatais por grupo de causas evitáveis (Lista Brasileira de Causas Evitáveis)	Total de óbitos neonatais em cada grupo da Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis por intervenções do SUS em menores de 5 anos, dividido pelo total de óbitos neonatais e multiplicado por 100.	Fonte: SIM-DO. Criada a variável GRUPO_LBE a partir de CAUSABAS, conforme a Lista de Tabulação de Causas Evitáveis de menores de 5 anos do DATASUS/SVS (Malta et al., 2007, atualizada em 2010). Regras de subcategoria (4 caracteres) têm precedência sobre regras de categoria (3 caracteres): "Reduzíveis por imunoprevenção" = A17, A19, A33, A35 a A37, A80, B05, B06, B16, B26, G00.0, P35.0, P35.3; "Reduzíveis por atenção à mulher na gestação" = A50, B20 a B24, P00, P01, P02.2, P02.3, P02.7 a P02.9, P04, P05, P07, P22.0, P26, P52, P55.0, P55.1, P55.8, P55.9, P56, P57, P77; "Reduzíveis por atenção à mulher no parto" = P02.0, P02.1, P02.4 a P02.6, P03, P08, P10 a P15, P20, P21, P24.0 a P24.2, P24.8, P24.9; "Reduzíveis por atenção ao recém-nascido" = P22.1, P22.8, P22.9, P23, P25, P27, P28, P35.1, P35.2, P35.4 a P35.9, P36 a P39, P50, P51, P53, P54, P58 a P61, P70 a P76, P78, P80 a P83, P90 a P94, P96.0 a P96.8; "Reduzíveis por diagnóstico e tratamento adequados" = A15, A16, A18, A30 a A32, A38 a A41, A46, A49, A70 a A74, E03.0, E03.1, E10 a E14, E70.0, E73.0, G00.1 a G00.9, G03, G40, G41, I00 a I09, J00 a J06, J12 a J18, J20 a J22, J38.4, J40 a J42, J45 a J47, J68, J69, N39.0, Q90; "Reduzíveis por promoção à saúde" = A00 a A09, A20 a A28, A75 a A79, A82, A90 a A99, B50 a B64, B65 a B83, B99, D50 a D53, E40 a E64, E86, R95 (síndrome da morte súbita) e causas externas V01 a V99, W00 a W19, W20 a W49, W65 a W74, W75 a W84, W85 a W99, X00 a X09, X30 a X39, X40 a X49, X85 a Y09, Y10 a Y34, Y40 a Y59, Y60 a Y69, Y83, Y84; "Causas mal definidas" = R00 a R94, R96 a R99, P95, P96.9; "Anomalias congênitas" = Q00 a Q99, exceto Q90 (linha apresentada em separado para leitura; na lista oficial esses códigos pertencem a "Demais causas, não claramente evitáveis"); "Demais causas (não claramente evitáveis)" = todos os outros códigos. Denominador: OBITO_NEONATAL = 1. A lista é definida para menores de 5 anos e é aplicada aqui apenas aos óbitos neonatais, dentro do seu escopo. Diferença em relação às planilhas anteriores: o script original usava uma tabela própria que alocava P22.0, P26, P52, P55 a P57 e P77 em "atenção ao recém-nascido"; na lista oficial esses códigos pertencem a "atenção à mulher na gestação".

6.1 Notas metodológicas do dicionário

1. Ocorrência versus nascimento. Todos os óbitos são atribuídos ao CNES do local de ocorrência (CODESTAB da DO ou da DOFET). A DO não informa o estabelecimento de nascimento, e as taxas neonatais e perinatais de maternidades de referência incluem recém-nascidos transferidos de outros serviços. A razão de mortalidade materna tem a mesma limitação para gestantes e puérperas transferidas. Os indicadores medem a mortalidade ocorrida na unidade, não o risco da população atendida.
2. Diferenças em relação às planilhas anteriores. Óbito materno: a regra anterior contava homens e óbitos por HIV (B20 a B24) com OBITOGRAV e OBITOPUERP ignorados, o que superestimava o número em 78 das 106 unidades; a regra atual é a do Ministério da Saúde. Causas evitáveis: substituição da tabela própria pela lista oficial. Neonatal: recuperação da idade pelo campo IDADE quando falta DTNASC. Fetal e perinatal: sem mudança de regra.
3. Dados preliminares. Os anos de 2024 e 2025 são preliminares e os totais podem mudar nas próximas versões dos arquivos do DATASUS.
4. Classificações próprias. Os grupos de causas dos óbitos fetais, perinatais e neonatais e os grupos de causas maternas diretas e indiretas seguem faixas de CID-10 definidas neste projeto e devem ser citados como tais.

6.2 Indicadores dos mapas e do comparador

O Painel de Mortalidade tem 38 indicadores de mapa e comparador, em cinco blocos (visão geral, materna, fetal, perinatal e neonatal), derivados das tabelas do dicionário, mas com denominadores próprios. As fichas abaixo são as da página "Metodologia" do painel. Nas tabelas do dossiê, os percentuais de peso e de momento do óbito incluem a categoria "Ignorado" (o total soma 100%); nos mapas e no comparador, os ignorados ficam fora do denominador.

Visão geral

Tabela 22 – Indicadores do bloco "Visão geral" (mapas e comparador)

Indicador	O que mede	Numerador	Denominador	Fonte, direção e observações
Nascidos vivos ocorridos	Total de nascidos vivos ocorridos na unidade (SINASC): denominador da razão de mortalidade materna e das taxas neonatais.	Nascidos vivos ocorridos na unidade no ano (SINASC, CODESTAB = CNES da unidade, ano de DTNASC), independentemente do município de residência da mãe.	Não se aplica: é um número absoluto.	SINASC Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.
Razão de mortalidade materna (por 100 mil NV)	Óbitos maternos ocorridos na unidade por 100 mil nascidos vivos ocorridos na unidade (definição do Ministério da Saúde para óbito materno).	Óbitos maternos ocorridos na unidade no ano (regra acima).	Nascidos vivos ocorridos na unidade no ano (SINASC), × 100.000. Sem fator de correção.	SIM-DO e SINASC Razão por estabelecimento de ocorrência: o numerador inclui mulheres cujo parto ocorreu em outro serviço ou transferidas; em unidades com poucos nascidos vivos, um único óbito produz valores altos — leia junto com o número absoluto. Quanto menor, melhor.
Taxa de mortalidade fetal (por mil nascimentos)	Óbitos fetais (22 semanas ou mais, ou 500 g ou mais) por mil nascimentos (nascidos vivos + óbitos fetais) ocorridos na unidade.	Óbitos fetais (regra acima).	Nascimentos ocorridos na unidade: nascidos vivos (SINASC) + óbitos fetais, × 1.000 (IDB C.5).	SIM-DOFET e SINASC Quanto menor, melhor.

Taxa de mortalidade perinatal (por mil nascimentos)	Óbitos fetais mais óbitos neonatais precoces (0 a 6 dias) por mil nascimentos ocorridos na unidade.	Óbitos perinatais (regra acima).	Nascimentos ocorridos na unidade: nascidos vivos + óbitos fetais, × 1.000 (IDB C.5).	SIM-DOFET, SIM-DO e SINASC O componente neonatal precoce é atribuído pelo local do óbito; a DO não informa o estabelecimento de nascimento. Em maternidades com UTI neonatal, recém-nascidos nascidos em outro serviço entram no numerador sem entrar no denominador. Quanto menor, melhor.
Taxa de mortalidade neonatal (por mil NV)	Óbitos de nascidos vivos com 0 a 27 dias de vida ocorridos na unidade por mil nascidos vivos ocorridos na unidade.	Óbitos neonatais (0 a 27 dias) ocorridos na unidade.	Nascidos vivos ocorridos na unidade (SINASC), × 1.000.	SIM-DO e SINASC Taxa por estabelecimento de ocorrência: inclui recém-nascidos transferidos de outros serviços (o denominador só tem os nascidos vivos da própria unidade). Não é comparável à taxa populacional do IDB. Quanto menor, melhor.

Mortalidade materna

Tabela 23 – Indicadores do bloco "Mortalidade materna" (mapas e comparador)

Indicador	O que mede	Numerador	Denominador	Fonte, direção e observações
Número de óbitos maternos	Óbitos de mulheres na gestação ou até 42 dias após o seu término, por causa relacionada ou agravada pela gravidez, ocorridos na unidade (regra do Ministério da Saúde).	Óbitos de mulheres (SEXO = feminino) ocorridos na unidade (CODESTAB) com causa básica (CAUSABAS) O00-O95, O98 ou O99; ou A34, F53, M83.0 com óbito no puerpério até 42 dias ou ignorado; ou B20-B24, D39.2, E23.0 somente quando OBITOGRAV = 1 ou OBITOPUERP = 1. Sem filtro de idade.	Não se aplica: é um número absoluto.	SIM-DO Regra do Ministério da Saúde (IDB C.3, Anexo I; Guia de Vigilância do Óbito Materno, 2009), a mesma do painel OOBr. Difere das planilhas anteriores a 10/09/2026, que contavam também homens e óbitos por HIV com os campos 43/44 ignorados. Quanto menor, melhor.
Razão de mortalidade materna (por 100 mil NV)	Óbitos maternos ocorridos na unidade por 100 mil nascidos vivos ocorridos na unidade.	Óbitos maternos ocorridos na unidade no ano (regra acima).	Nascidos vivos ocorridos na unidade no ano (SINASC), × 100.000. Sem fator de correção.	SIM-DO e SINASC Razão por estabelecimento de ocorrência: o numerador inclui mulheres cujo parto ocorreu em outro serviço ou transferidas; em unidades com poucos nascidos vivos, um único óbito produz valores altos — leia junto com o número absoluto. Quanto menor, melhor.
% de óbitos maternos por causas obstétricas diretas	Entre os óbitos maternos, proporção por causas obstétricas diretas (complicações da gravidez, parto e puerpério).	Óbitos maternos por causas obstétricas diretas: O00-O08, O11-O23, O24.4, O26-O92, A34, D39.2, E23.0, F53, M83.0.	Total de óbitos maternos da unidade no ano.	SIM-DO Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.

% de óbitos maternos por causas obstétricas indiretas	Entre os óbitos maternos, proporção por causas obstétricas indiretas (doenças pré-existentes ou que surgiram na gravidez, agravadas por ela).	Óbitos maternos por causas obstétricas indiretas: O10, O24 (exceto O24.4), O25, O94, O98, O99, B20-B24.	Total de óbitos maternos da unidade no ano. Os óbitos O95 (inespecíficos) completam o total.	SIM-DO Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.
% dos óbitos maternos diretos por hipertensão	Entre os óbitos maternos por causas diretas, proporção por hipertensão (pré-eclâmpsia/eclâmpsia, O11 a O16).	Óbitos maternos diretos por hipertensão: O11 a O16.	Total de óbitos maternos por causas diretas.	SIM-DO Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.
% dos óbitos maternos diretos por hemorragia	Entre os óbitos maternos por causas diretas, proporção por hemorragia (O20, O44 a O46, O67, O72).	Óbitos maternos diretos por hemorragia: O20, O44, O45, O46, O67, O72.	Total de óbitos maternos por causas diretas.	SIM-DO Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.
% dos óbitos maternos diretos por infecção puerperal	Entre os óbitos maternos por causas diretas, proporção por infecção puerperal (O85, O86, O91).	Óbitos maternos diretos por infecção puerperal: O85, O86, O91.	Total de óbitos maternos por causas diretas.	SIM-DO Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.

Mortalidade fetal

Tabela 24 – Indicadores do bloco "Mortalidade fetal" (mapas e comparador)

Indicador	O que mede	Numerador	Denominador	Fonte, direção e observações
Número de óbitos fetais	Óbitos fetais com 22 semanas ou mais de gestação ou 500 g ou mais, ocorridos na unidade.	Declarações de óbito fetal (SIM-DOFET) da unidade com SEMAGESTAC ≥ 22 semanas ou PESO ≥ 500 g.	Não se aplica: é um número absoluto.	SIM-DOFET Registros com os dois campos ignorados não entram (opção conservadora; o IDB recomenda incluí-los). A DO fetal é obrigatória a partir de 20 semanas, por isso o arquivo tem registros abaixo do limite estatístico. Quanto menor, melhor.
Taxa de mortalidade fetal (por mil nascimentos)	Óbitos fetais por mil nascimentos (nascidos vivos + óbitos fetais) ocorridos na unidade.	Óbitos fetais (regra acima).	Nascimentos ocorridos na unidade: nascidos vivos (SINASC) + óbitos fetais, × 1.000 (IDB C.5).	SIM-DOFET e SINASC Quanto menor, melhor.
% de óbitos fetais anteparto	Entre os óbitos fetais com momento informado, proporção ocorrida antes do trabalho de parto.	Óbitos fetais com OBITOPARTO = 1 (antes do parto).	Óbitos fetais com momento informado (exclui ignorado).	SIM-DOFET Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.
% de óbitos fetais intraparto	Entre os óbitos fetais com momento informado, proporção ocorrida durante o parto — óbitos potencialmente sensíveis à assistência ao parto.	Óbitos fetais com OBITOPARTO = 2 (durante o parto).	Óbitos fetais com momento informado (exclui ignorado).	SIM-DOFET Quanto menor, melhor.
% de óbitos fetais com peso <1500 g	Entre os óbitos fetais com peso informado, proporção com menos de 1500 g.	Óbitos fetais com peso de 100 a 1499 g.	Óbitos fetais com peso informado (100 a 8.000 g).	SIM-DOFET Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.

% de óbitos fetais com peso ≥2500 g	Entre os óbitos fetais com peso informado, proporção com 2500 g ou mais — fetos a termo ou próximos do termo, óbitos em geral mais evitáveis.	Óbitos fetais com peso de 2500 g ou mais.	Óbitos fetais com peso informado (100 a 8.000 g).	SIM-DOFET Quanto menor, melhor.
% de óbitos fetais por causas mal definidas	Entre os óbitos fetais, proporção com causa básica mal definida (R00 a R99, P95) — indicador da qualidade da investigação do óbito.	Óbitos fetais com causa básica R00-R99 ou P95.	Total de óbitos fetais.	SIM-DOFET Quanto menor, melhor.

Mortalidade perinatal

Tabela 25 – Indicadores do bloco "Mortalidade perinatal" (mapas e comparador)

Indicador	O que mede	Numerador	Denominador	Fonte, direção e observações
Número de óbitos perinatais	Óbitos fetais (22 semanas ou mais, ou 500 g ou mais) mais óbitos neonatais precoces (0 a 6 dias) ocorridos na unidade.	Óbitos fetais (≥22 semanas ou ≥500 g) + óbitos de nascidos vivos com 0 a 6 dias de vida (SIM-DO) ocorridos na unidade.	Não se aplica: é um número absoluto.	SIM-DOFET e SIM-DO Quanto menor, melhor.
Taxa de mortalidade perinatal (por mil nascimentos)	Óbitos perinatais por mil nascimentos (nascidos vivos + óbitos fetais) ocorridos na unidade.	Óbitos perinatais (regra acima).	Nascimentos ocorridos na unidade: nascidos vivos + óbitos fetais, × 1.000 (IDB C.5).	SIM-DOFET, SIM-DO e SINASC O componente neonatal precoce é atribuído pelo local do óbito; a DO não informa o estabelecimento de nascimento. Em maternidades com UTI neonatal, recém-nascidos nascidos em outro serviço entram no numerador sem entrar no denominador. Quanto menor, melhor.
% do componente fetal na mortalidade perinatal	Entre os óbitos perinatais, proporção de óbitos fetais (o restante são óbitos neonatais precoces).	Óbitos fetais (componente fetal).	Total de óbitos perinatais.	SIM-DOFET e SIM-DO Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.
% de óbitos perinatais com peso <1500 g	Entre os óbitos perinatais com peso informado, proporção com menos de 1500 g.	Óbitos perinatais com peso de 100 a 1499 g.	Óbitos perinatais com peso informado.	SIM-DOFET e SIM-DO Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.
% de óbitos perinatais por hipóxia/asfixia e transtornos respiratórios	Entre os óbitos perinatais, proporção por hipóxia/asfixia e transtornos respiratórios (P10 a P15, P20, P21, P24, P28).	Óbitos perinatais com causa básica P10-P15, P20, P21, P24, P28.	Total de óbitos perinatais.	SIM-DOFET e SIM-DO Quanto menor, melhor.

% de óbitos perinatais por anomalias congênitas	Entre os óbitos perinatais, proporção por anomalias congênitas (capítulo XVII da CID-10).	Óbitos perinatais com causa básica Q00-Q99.	Total de óbitos perinatais.	SIM-DOFET e SIM-DO Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.

Mortalidade neonatal

Tabela 26 – Indicadores do bloco "Mortalidade neonatal" (mapas e comparador)

Indicador	O que mede	Numerador	Denominador	Fonte, direção e observações
Número de óbitos neonatais (0 a 27 dias)	Óbitos de nascidos vivos com 0 a 27 dias completos de vida ocorridos na unidade.	Óbitos de nascidos vivos com 0 a 27 dias completos de vida ocorridos na unidade (SIM-DO). Idade = DTOBITO − DTNASC; sem DTNASC, recuperada do campo IDADE (minutos/horas = 0 dias; dias = quantidade).	Não se aplica: é um número absoluto.	SIM-DO Quanto menor, melhor.
Taxa de mortalidade neonatal (por mil NV)	Óbitos neonatais (0 a 27 dias) por mil nascidos vivos ocorridos na unidade.	Óbitos neonatais (0 a 27 dias) ocorridos na unidade.	Nascidos vivos ocorridos na unidade (SINASC), × 1.000.	SIM-DO e SINASC Taxa por estabelecimento de ocorrência: inclui recém-nascidos transferidos de outros serviços (o denominador só tem os nascidos vivos da própria unidade). Não é comparável à taxa populacional do IDB. Quanto menor, melhor.
Taxa de mortalidade neonatal precoce (por mil NV)	Óbitos de 0 a 6 dias de vida por mil nascidos vivos ocorridos na unidade (IDB C.1.1).	Óbitos de 0 a 6 dias de vida ocorridos na unidade.	Nascidos vivos ocorridos na unidade, × 1.000 (IDB C.1.1).	SIM-DO e SINASC Quanto menor, melhor.
Taxa de mortalidade neonatal tardia (por mil NV)	Óbitos de 7 a 27 dias de vida por mil nascidos vivos ocorridos na unidade (IDB C.1.2).	Óbitos de 7 a 27 dias de vida ocorridos na unidade.	Nascidos vivos ocorridos na unidade, × 1.000 (IDB C.1.2).	SIM-DO e SINASC Quanto menor, melhor.
% de óbitos neonatais no 1º dia de vida	Entre os óbitos neonatais, proporção ocorrida nas primeiras 24 horas de vida.	Óbitos neonatais com 0 dias de vida (primeiras 24 horas).	Total de óbitos neonatais.	SIM-DO Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.

% de óbitos neonatais com peso <1500 g	Entre os óbitos neonatais com peso informado, proporção com menos de 1500 g.	Óbitos neonatais com peso de 100 a 1499 g.	Óbitos neonatais com peso informado.	SIM-DO Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.
% de óbitos neonatais com peso ≥2500 g	Entre os óbitos neonatais com peso informado, proporção com 2500 g ou mais — recém-nascidos de peso adequado, óbitos em geral mais evitáveis.	Óbitos neonatais com peso de 2500 g ou mais.	Óbitos neonatais com peso informado.	SIM-DO Quanto menor, melhor.
% de óbitos neonatais por causas evitáveis (LBE)	Entre os óbitos neonatais, proporção por causas evitáveis por intervenções do SUS (Lista Brasileira: imunoprevenção, atenção à gestação, ao parto, ao recém-nascido, diagnóstico/tratamento e promoção à saúde).	Óbitos neonatais nos seis grupos de causas evitáveis da Lista Brasileira (imunoprevenção; atenção à mulher na gestação; no parto; ao recém-nascido; diagnóstico e tratamento; promoção à saúde).	Total de óbitos neonatais.	SIM-DO Quanto menor, melhor.
% de óbitos neonatais reduzíveis por atenção à mulher na gestação	Entre os óbitos neonatais, proporção por causas reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação (LBE).	Óbitos neonatais reduzíveis por atenção à mulher na gestação: A50, B20-B24, P00, P01, P02.2, P02.3, P02.7-P02.9, P04, P05, P07, P22.0, P26, P52, P55.0, P55.1, P55.8, P55.9, P56, P57, P77.	Total de óbitos neonatais.	SIM-DO Quanto menor, melhor.
% de óbitos neonatais reduzíveis por atenção à mulher no parto	Entre os óbitos neonatais, proporção por causas reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto (LBE).	Óbitos neonatais reduzíveis por atenção à mulher no parto: P02.0, P02.1, P02.4-P02.6, P03, P08, P10-P15, P20, P21, P24.0-P24.2, P24.8, P24.9.	Total de óbitos neonatais.	SIM-DO Quanto menor, melhor.

% de óbitos neonatais reduzíveis por atenção ao recém-nascido	Entre os óbitos neonatais, proporção por causas reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido (LBE).	Óbitos neonatais reduzíveis por atenção ao recém-nascido: P22.1, P22.8, P22.9, P23, P25, P27, P28, P35.1, P35.2, P35.4-P35.9, P36-P39, P50, P51, P53, P54, P58-P61, P70-P76, P78, P80-P83, P90-P94, P96.0-P96.8.	Total de óbitos neonatais.	SIM-DO Quanto menor, melhor.
% de óbitos neonatais por causas mal definidas	Entre os óbitos neonatais, proporção com causa básica mal definida (R00 a R99, P95) — qualidade da investigação do óbito.	Óbitos neonatais com causa básica R00-R99 ou P95.	Total de óbitos neonatais.	SIM-DO Quanto menor, melhor.
% de óbitos neonatais por anomalias congênitas	Entre os óbitos neonatais, proporção por anomalias congênitas (capítulo XVII da CID-10).	Óbitos neonatais com causa básica Q00-Q99.	Total de óbitos neonatais.	SIM-DO Sem direção definida: não entra no destaque de melhor posição.

Demais cálculos do painel

Tabela 27 – Demais cálculos do Painel de Mortalidade

Cálculo	O que mede	Numerador	Denominador	Fonte
Grupos de causas dos óbitos fetais, perinatais e neonatais (tabelas do dossiê)	Classificação própria do projeto por faixas da CID-10, com precedência na ordem listada. Não há lista oficial do Ministério da Saúde para este recorte (a OMS publica a ICD-PM).	Fatores maternos, placenta, cordão e membranas = P00-P04 · Gestação e crescimento fetal = P05, P07, P08 · Hipóxia/asfixia e transtornos respiratórios = P10-P15, P20, P21, P24, P28 · Infecções perinatais = P35-P39, A50 · Anomalias congênitas = Q00-Q99 · Hemorrágicos e hematológicos = P50-P61 · Mal definidas = R00-R99, P95 · Demais causas = outros códigos.	Total de óbitos do bloco (fetal, perinatal ou neonatal) na unidade e no ano; a linha Total soma 100%.	Ministério da Saúde - SIM (DO e DOFET), 2019 a 2025.
Grupos de causas maternas diretas e indiretas (tabelas do dossiê)	Classificação por faixas da CID-10 aplicada aos óbitos maternos, com precedência na ordem listada.	Diretas: Aborto = O00-O08 · Hipertensão = O11-O16 · Hemorragia = O20, O44-O46, O67, O72 · Infecção puerperal = O85, O86, O91 · Tromboembolismo = O88 · Outras diretas = demais causas diretas. Indiretas: Infecciosas e parasitárias = O98, B20-B24 · Cardiopatias = O99.4 · Respiratórias = O99.5 · Hipertensão/diabetes pré-existentes = O10, O24 (exceto O24.4), O25 · Outras afecções maternas = O99 (demais), O94.	Total de causas diretas ou de causas indiretas da unidade no ano (os percentuais das tabelas). Óbitos O95 não entram nos grupos.	Ministério da Saúde - SIM-DO, 2019 a 2025.
Faixas de peso ao nascer (tabelas do dossiê)	Categorias do campo PESO (gramas) das declarações de óbito e de óbito fetal.	Menos de 1000 g (100 a 999) · 1000 a 1499 g · 1500 a 2499 g · 2500 a 3999 g · 4000 g e mais (4.000 a 8.000) · Ignorado (branco, 0, 9999 ou fora de 100 a 8.000).	Total de óbitos do bloco na unidade e no ano.	Ministério da Saúde - SIM (DO e DOFET), 2019 a 2025.

Agregado do grupo (comparador)	Coluna de referência do comparador de unidades: a maternidade é comparada com o conjunto do seu grupo (apoiadas, EBSERH ou QUALINEO 2026/2027). Unidades que pertencem a mais de um grupo contam em todos os grupos a que pertencem. O agregado não participa do destaque de menor valor.	Soma dos numeradores do indicador nas unidades do grupo com dado no ano (nos números absolutos, média por unidade).	Soma dos denominadores correspondentes nas mesmas unidades — a mesma regra de agregação usada nos mapas e no painel lateral.	Ministério da Saúde - SIM e SINASC, 2019 a 2025.
HCFAMEMA (Marília/SP): complexo hospitalar	Os CNES 2025507 (hospital adulto) e 2025523 (unidade materno-infantil) são tratados como um único complexo.	Óbitos dos dois códigos CNES.	Nascidos vivos do CNES 2025523 (unidade materno-infantil).	Ministério da Saúde - SIM e SINASC, 2019 a 2025.

7. Notas comuns aos três painéis

7.1 Notas gerais

- **Dados preliminares.** Os anos mais recentes são preliminares: SINASC 2025 nos painéis de Nascimentos e de Internação, e 2024 e 2025 no Painel de Mortalidade; SIM 2024 e 2025; SIH 2025 sujeito a acréscimos; e, nos três painéis, o 1º semestre de 2026. Os totais podem mudar nas próximas versões dos arquivos do DATASUS. Painéis e apresentações trazem a nota "dados sujeitos a revisão".
- **Período parcial (1º semestre de 2026).** Desde 18 de outubro de 2026 os painéis trazem a coluna "1º sem. 2026": nascidos vivos de janeiro a junho de 2026 (data de nascimento), óbitos de janeiro a junho (data do óbito) e internações de janeiro a junho (data de internação), calculados com as mesmas regras das colunas de 2019 a 2025, a partir dos arquivos preliminares de 2026. Por ser um semestre, a coluna não entra na coluna Total (acumulado), que continua 2019 a 2025, nem nas linhas de tendência; os seletores de ano abrem no último ano completo; e os números absolutos do semestre (nascidos vivos, internações, óbitos) não são comparáveis com anos completos, enquanto percentuais, taxas e tempos médios são. No Painel de Internação, a coluna usa as AIH apresentadas até a competência de agosto de 2026: medido em 2025, esse recorte já continha de 97,5% a 99,6% das internações do semestre, conforme a UF, e o restante entra nas competências seguintes. A página "Metodologia" de cada painel registra a fonte, a data da extração e as unidades sem registro no período.
- **Ocorrência e residência.** Nascimentos e óbitos são atribuídos ao estabelecimento onde ocorreram. A Declaração de Óbito não informa o estabelecimento de nascimento; por isso as taxas neonatais e perinatais de maternidades de referência incluem recém-nascidos transferidos de outros serviços, e a razão de mortalidade materna tem a mesma limitação para gestantes e puérperas transferidas. Os indicadores medem o que ocorreu na unidade, não o risco da população atendida. No Painel de Nascimentos, o dossiê mostra as duas perspectivas, local de residência e local de ocorrência (seção 4.3).
- **Datas de referência.** Internações: ano da data de internação. Óbitos: ano da data do óbito. Nascidos vivos: ano da data de nascimento.
- **Regras aprovadas.** Internação e perfil da mãe: Dicionário de indicadores de internação (AIH) do grupo de maternidades, versão final de 10 de setembro de 2026, que consolida as decisões da coordenação de 30 de agosto a 9 de setembro de 2026. Mortalidade: Dicionário de indicadores de mortalidade do grupo de maternidades, de 11 de setembro de 2026. Nascimentos: fichas da página "Metodologia" do painel e nota metodológica do comparador, de agosto de 2026.
- **Limitações de registro no SIH.** A diária de acompanhante registra diárias faturadas, não a presença durante o trabalho de parto. O registro de transfusão e o de histerectomia no SIH ficam em torno de 50% e 36%,

respectivamente (Domingues et al., 2024). Partos em centro de parto normal faturados pelo código comum de parto não são captados.

- **Classificações próprias.** Os grupos de causas dos óbitos fetais, perinatais e neonatais e os grupos de causas maternas diretas e indiretas seguem faixas de CID-10 definidas no projeto de mortalidade e devem ser citados como classificação própria.
- **Atualização dos painéis.** A ficha CNES e as habilitações são atualizadas automaticamente em 1º de junho e 1º de dezembro. A página principal dos painéis mostra, sob o botão de cada painel, a data da última atualização dos dados e, na nota de fontes, a data da ficha CNES.
- **Rodapé das apresentações de internação.** O modelo original citava o SIM como fonte; a fonte dos indicadores de internação é o SIH/SUS.

7.2 Situação dos anos preliminares, por base e painel

Tabela 28 – Anos e períodos tratados como preliminares em cada painel (18/10/2026)

Base	Painel de Nascimentos	Painel de Internação	Painel de Mortalidade
SINASC	2025 e 1º sem. 2026	2025 e 1º sem. 2026 (linhas do SINASC)	2024, 2025 e 1º sem. 2026 (marca aplicada à tabela inteira do painel)
SIH/SUS	—	2025 (sujeito a acréscimos) e 1º sem. 2026 (competências até agosto de 2026)	—
SIM	—	—	2024, 2025 e 1º sem. 2026

8. Glossário de siglas e termos

Tabela 29 – Siglas e termos usados na apostila

Sigla ou termo	Significado
AIH	Autorização de Internação Hospitalar: registro de cada internação financiada pelo SUS (base do SIH/SUS).
AMIU	Aspiração manual intrauterina; procedimento SIGTAP 0409060070.
ANS e QUALISS	Agência Nacional de Saúde Suplementar e seu Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços de Saúde, citado na ficha de taxa de ocupação (E-EFI-02).
Apgar	Escore de vitalidade do recém-nascido; o painel usa o Apgar do 5º minuto (campo APGAR5).
API	Serviço de acesso automatizado a dados pela internet (do inglês application programming interface).
Apoiadas	Rótulo das maternidades estratégicas na lista oficial e nos painéis de Internação e de Mortalidade.
CAUSABAS	Causa básica do óbito, código CID-10, na Declaração de Óbito.
CID-10	Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão. Códigos de diagnóstico e de causa básica de óbito.
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. O código CNES de 7 dígitos identifica cada unidade.
COBRANCA	Campo da AIH com o motivo de saída ou permanência (1x alta, 2x permanência, 3x transferência, 4x óbito, 51 encerramento administrativo, 6x desfechos de parto).
CODESTAB	Código CNES do estabelecimento de ocorrência, nas declarações de nascido vivo e de óbito.
CODLEITO e QT_EXIST	Código do tipo de leito e quantidade de leitos existentes, nos arquivos de leitos (LT) do CNES.
Comparador	Tela do painel que compara unidades do mesmo grupo e a mesma unidade entre anos (seção 1.3).
Competência	Mês em que a internação foi processada e paga pelo SUS; pode ser posterior ao mês da alta.
CPAV	Condições potencialmente ameaçadoras à vida (morbidade materna grave pelo critério do OOBr; morbidade neonatal grave por critérios pragmáticos).
CPN	Centro de Parto Normal; procedimento SIGTAP 0310010055.
DATASUS	Departamento de Informática do SUS, do Ministério da Saúde, que publica as bases usadas nos painéis.
DIAR_ACOM	Número de diárias de acompanhante registradas na AIH.
DIAS_PERM	Dias de permanência da internação: data de saída menos data de internação (DT_SAIDA − DT_INTER).
DN	Declaração de Nascido Vivo, documento de origem do SINASC.
DO e DOFET	Declaração de Óbito e Declaração de Óbito Fetal, documentos de origem do SIM.

Dossiê	Página de detalhe de cada maternidade no painel (seção 1.3).
EBSERH	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; grupo dos hospitais universitários federais do painel.
FTP	Servidor de arquivos do DATASUS na internet (do inglês file transfer protocol).
Habilitações	Serviços que o SUS autoriza o estabelecimento a realizar, registrados no CNES.
ICD-PM	Classificação da OMS para causas de óbitos perinatais (CID-PM), citada no dicionário de mortalidade.
IDB	Indicadores e Dados Básicos para a Saúde, da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), publicados pelo DATASUS; fichas C.1.1, C.1.2, C.3 e C.5.
IDENT	Campo da AIH que identifica o tipo de AIH (5 = longa permanência).
Ignorado	Registro com o campo em branco ou com código de "ignorado" (9, 99, 9999); fica fora do numerador e do denominador, salvo indicação em contrário.
LBE	Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções do SUS, na versão de tabulação para menores de 5 anos do DATASUS/SVS.
LT	Arquivos de leitos do CNES, por estabelecimento e mês.
MARCA_UTI	Campo da AIH com o tipo de UTI usado (81 e 82 = UTI neonatal tipos II e III).
Microdados	Registros individuais de uma base (um por nascimento, internação ou óbito), publicados sem identificação pessoal.
MMG	Morbidade materna grave.
MS	Ministério da Saúde.
NV	Nascidos vivos.
OMS	Organização Mundial da Saúde.
OOBr	Observatório Obstétrico Brasileiro.
OpenDataSUS	Portal de dados abertos do Ministério da Saúde.
OPM	Órteses, próteses e materiais especiais (na SIGTAP).
PROC_REA	Procedimento realizado, registrado na AIH (código SIGTAP).
QUALINEO	Nos painéis, grupo das maternidades participantes do ciclo 2026/2027 do QUALINEO, do Ministério da Saúde.
RD e SP	Arquivos do SIH/SUS: AIH reduzida (RD, um registro por internação) e serviços profissionais (SP, um registro por procedimento ou ato).
Regionalização	Divisão do território em regiões e macrorregiões de saúde, conforme a base territorial do DATASUS.

RMM	Razão de mortalidade materna: óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos.
Robson	Classificação de Robson, em dez grupos, para analisar a taxa de cesárea (seção 4.6).
SDR	Síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido (CID-10 P22.0).
SIGTAP	Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.
SIH/SUS	Sistema de Informações Hospitalares do SUS.
SIM	Sistema de Informações sobre Mortalidade.
SINASC	Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.
SP_ATOPROF	Ato profissional registrado no arquivo de serviços profissionais (SIH-SP), código SIGTAP.
SUS	Sistema Único de Saúde.
SVS	Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde.
TabNet e TabWin	Ferramentas de tabulação do DATASUS, na internet e em programa para computador.
TMP	Tempo médio de permanência.
TPROBSON	Campo do SINASC com o código do grupo de Robson, gerado pelo sistema (seção 4.6).
UF	Unidade da federação (estado ou Distrito Federal).
Universo obstétrico	Internações de mulheres de 10 a 59 anos com diagnóstico O00 a O99 em qualquer campo de diagnóstico da AIH (seção 5).
UTI_MES_TO	Total de diárias de UTI registradas na AIH.
UTIN	Unidade de terapia intensiva neonatal (leitos CNES 81 e 82, tipos II e III; o leito 80, tipo I, só na regra transitória de 5 de setembro de 2026; MARCA_UTI 81 e 82 na AIH).
VBAC	Parto vaginal após cesariana (do inglês vaginal birth after cesarean).

9. Referências

As referências estão agrupadas por tipo. As citações de artigos científicos reproduzem a forma usada nos dicionários de origem (autor e ano).

9.1 Bases de dados e sistemas

- Ministério da Saúde. SINASC: microdados públicos, um arquivo por ano, no OpenDataSUS. dadosabertos.saude.gov.br/dataset/sistema-de-informacao-sobre-nascidos-vivos-sinasc. Acesso em 11 out. 2026.
- Ministério da Saúde. SINASC: estrutura dos arquivos (dicionário de campos), versão de 22 fev. 2024. diaad.s3.sa-east-1.amazonaws.com/sinasc/SINASC+-+Estrutura.pdf. Acesso em 11 out. 2026.
- Ministério da Saúde. SIH/SUS: arquivos RD e SP, competências de 01/2019 a 06/2026 (colunas de 2019 a 2025) e até 08/2026 (1º semestre de 2026). FTP do DATASUS, pasta dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/Dados. Acesso em set. e out. 2026.
- Ministério da Saúde. SIM: arquivos DO (pastas SIM/CID10/DORES e SIM/PRELIM/DORES) e DOFET (SIM/CID10/DOFET e SIM/PRELIM/DOFET), 2019 a 2025 e preliminares de 2026. FTP do DATASUS. Extração em 10, 11 e 23 set. 2026 e, para 2026, em 18 out. 2026.
- Ministério da Saúde. CNES: ficha de estabelecimento pela API de Dados Abertos (apidadosabertos.saude.gov.br/cnes/estabelecimentos), habilitações pelo portal cnes.datasus.gov.br e arquivos de leitos (LT) no FTP do DATASUS (CNES/200508_/Dados/LT). Atualização em 11 out. 2026.
- Ministério da Saúde. Base territorial do DATASUS (município, região de saúde e macrorregião), versão de jun. 2026, e malhas das regiões e macrorregiões de saúde.

9.2 Normas

- Lei nº 11.108, de 2005 (direito a acompanhante no parto); Portaria GM/MS nº 2.418/2005 (cobrança das despesas com acompanhante na AIH); Portaria GM/MS nº 1.459/2011, art. 7º.
- Portaria GM/MS nº 11/2015, art. 51 (Centro de Parto Normal); Portaria SAES/MS nº 1.549/2024 (laqueadura tubária na internação do parto normal, vigente desde a competência 04/2024).
- Portaria GM/MS nº 930/2012 e Portaria GM/MS nº 2.862/2023 (UTI neonatal); Portaria SAES/MS nº 2.902/2025 (reclassificação dos leitos de UTI neonatal tipo I).
- Portaria SAS/MS nº 312/2002 (estatísticas hospitalares; taxa de ocupação); Portaria SAS/MS nº 719/2007 e Portaria SAS/MS nº 384/2010 (motivos de saída da AIH); Manual Técnico Operacional do SIH/SUS (2017), item 6.3.

- Portaria SVS/MS nº 116/2009 (declaração de óbito fetal).
- Lei nº 9.504, de 1997, art. 73, VI, b (condutas vedadas no período eleitoral; identidade visual desta apostila); Decreto nº 8.777, de 2016 (política de dados abertos).

9.3 Documentos técnicos oficiais

- Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA); DATASUS. Indicadores e Dados Básicos (IDB), capítulo C, Mortalidade: fichas C.1.1, C.1.2, C.3 e Anexo I, e C.5. tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/CapituloC.pdf.
- DATASUS; Secretaria de Vigilância em Saúde. Óbitos por causas evitáveis de 0 a 4 anos: notas técnicas e Lista de Tabulação de Causas Evitáveis de menores de 5 anos (Malta et al., 2007, atualizada em 2010). tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/Obitos_Evitaveis_0_a_4_anos.pdf.
- Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica do Óbito Materno. Brasília, 2009.
- Ministério da Saúde. Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento. Brasília, 2014.
- Ministério da Saúde. SIGTAP: Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.
- DATASUS. Nota técnica sobre o campo DIAS_PERM do SIH/SUS (inclui dias de UTI), citada no dicionário de indicadores AIH.
- DATASUS; Secretaria de Vigilância em Saúde. Dicionários de variáveis do SIM e do SINASC e Manual de preenchimento da Declaração de Nascido Vivo.
- Organização Mundial da Saúde. Recomendações sobre cuidados pré-natais para uma experiência positiva na gravidez. 2016.
- Organização Mundial da Saúde. CID-10, volume 2 (limites para as estatísticas perinatais) e ICD-PM (classificação de óbitos perinatais).
- Organização Mundial da Saúde. Declaração da OMS sobre Taxas de Cesáreas (WHO/RHR/15.02), 2015, versão em português; Quadro 1, classificação de Robson. Cópia hospedada no ProQualis/Fiocruz: proqualis.fiocruz.br/sites/proqualis.fiocruz.br/files/WHO_RHR_15.02_por.pdf. Acesso em 11 out. 2026.
- World Health Organization. Robson Classification: Implementation Manual. Geneva: WHO, 2017. ISBN 978-92-4-151319-7; Tabela 8 (valores de referência por grupo). who.int/publications/i/item/9789241513197. Acesso em 11 out. 2026.
- Observatório Obstétrico Brasileiro (OOBr). Painel de Vigilância da Saúde Materna (condições potencialmente ameaçadoras à vida no SIH/SUS) e painel Óbitos de Gestantes e Puérperas (regra de óbito materno). Código-fonte: github.com/observatorioobstetrico/painel-obitos-grav-puerp.
- Agência Nacional de Saúde Suplementar. Programa QUALISS, ficha técnica E-EFI-02 (taxa de ocupação).
- Livro Verde 2026, capítulo 3: fichas de qualificação de indicadores hospitalares. DOI 10.5281/zenodo.18273581.

9.4 Artigos científicos citados nos dicionários

- Domingues et al., 2024 (morbidade materna grave e limitações de registro no SIH; base do critério do OOBr).
- Nakamura-Pereira et al., 2013 (limitações de registro no SIH).
- Jacobs e Boing, 2021 (interrupção da gestação prevista em lei no SIH).
- Pileggi et al., 2010; Silva et al., 2014; Kale et al., 2017 (critérios pragmáticos de morbidade neonatal grave).
- Malta et al., 2007 e 2010 (Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis).

9.5 Documentos do projeto

- Dicionário de indicadores de internação (AIH) do grupo de maternidades, versão final de 10 de setembro de 2026 (Projeto Apresentações Internação).
- Dicionário de indicadores de mortalidade do grupo de maternidades, versão de 11 de setembro de 2026 (Mortalidade Indicadores).
- Nota metodológica: comparação da unidade com a média do seu grupo, Painel NV 2026, agosto de 2026.
- Páginas "Metodologia" dos painéis de Nascimentos, Internação e Mortalidade, publicadas em https://anamazza.github.io/Indicadores_Brasil/, e documentação do repositório Indicadores_Brasil (GitHub).